Estratégia MED



# CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

## ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO - DIVERTICULITE AGUDA

CURSO EXTENSIVO 2024




APRESENTAÇÃO

# PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno, questões sobre diverticulite aguda são frequentes nas provas de Residência e quase sempre envolvem a Classificação de Hinchey e o tratamento, veja nos gráficos a seguir.

Neste livro, discutiremos apenas sobre a diverticulite aguda, uma complicação da doença diverticular. A epidemiologia, os fatores de risco e a patogênese da diverticulose e doença diverticular serão abordados no livro de "Doença diverticular".

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

@prof.renathapaiva

/estrategiamed

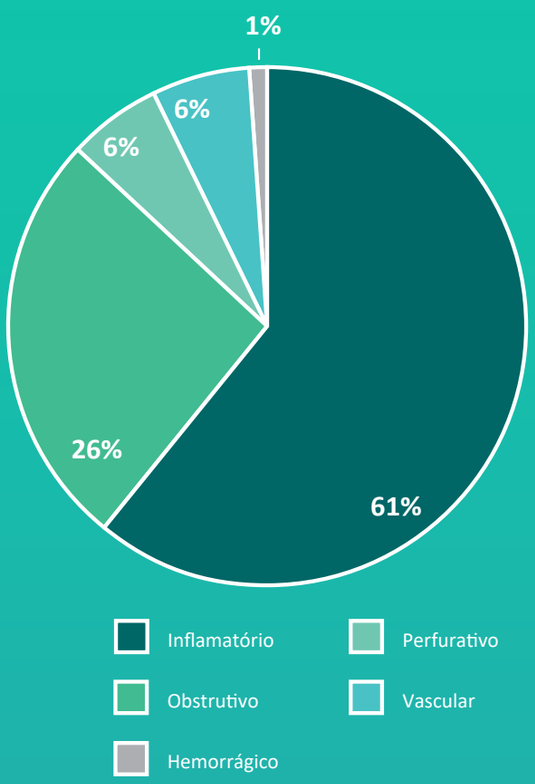
Estratégia MED

@estrategiamed

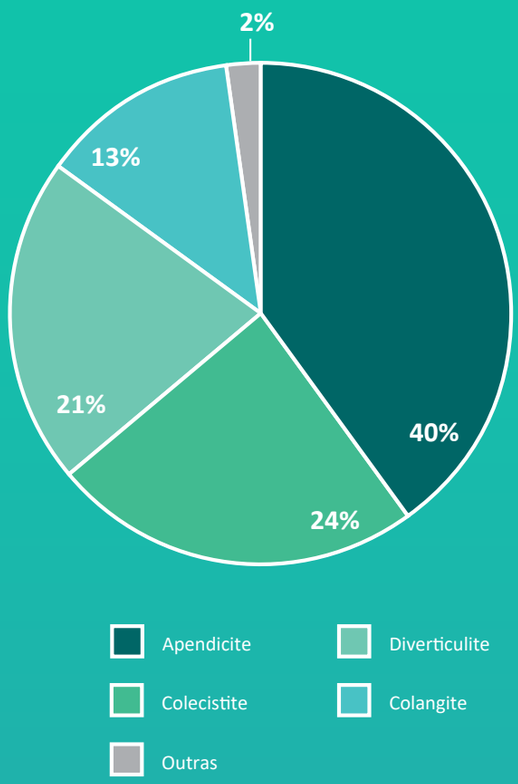
Estratégia MED

Veja como é cobrado o tema diverticulite aguda nas provas de Residência Médica:

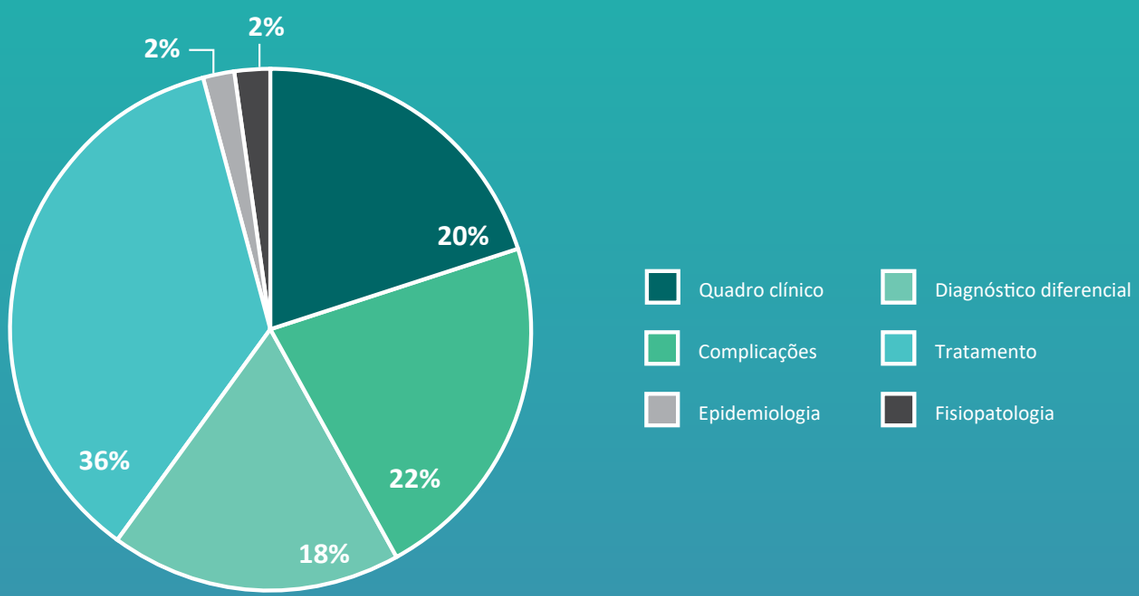
## ABDOME AGUDO




## ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO




## DIVERTICULITE AGUDA



# SUMÁRIO


1.0 DIVERTICULITE AGUDA 5

1.1 INTRODUÇÃO 5

1.2 EPIDEMIOLOGIA 5

1.3 FISIOPATOLOGIA 6

1.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 8

1.5 COMPLICAÇÕES 10

1.6 EXAMES COMPLEMENTARES 15

1.6.1 LABORATÓRIO 15

1.6.2 EXAMES DE IMAGEM 15

1.7 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 17

1.8 TRATAMENTO 21

1.8.1 CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY 21

1.8.2 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE NÃO COMPLICADA 24

1.8.3 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE COMPLICADA 25

1.8.4 DIVERTICULITE DO LADO DIREITO 28

1.9 PÓS TRATAMENTO DA DIVERTICULITE 37

1.10 CIRURGIA ELETIVA 37

1.11 PROGNÓSTICO 42

2.0 MAPA MENTAL 43

3.0 LISTA DE QUESTÕES 44

4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 45

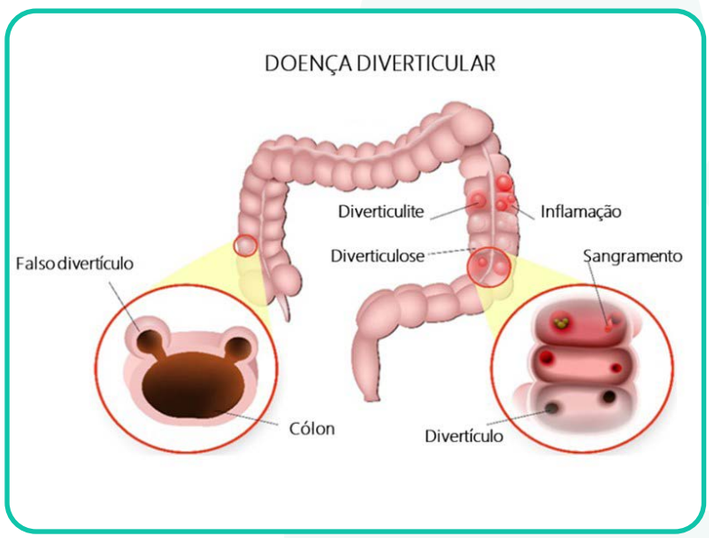
5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 45

CAPÍTULO

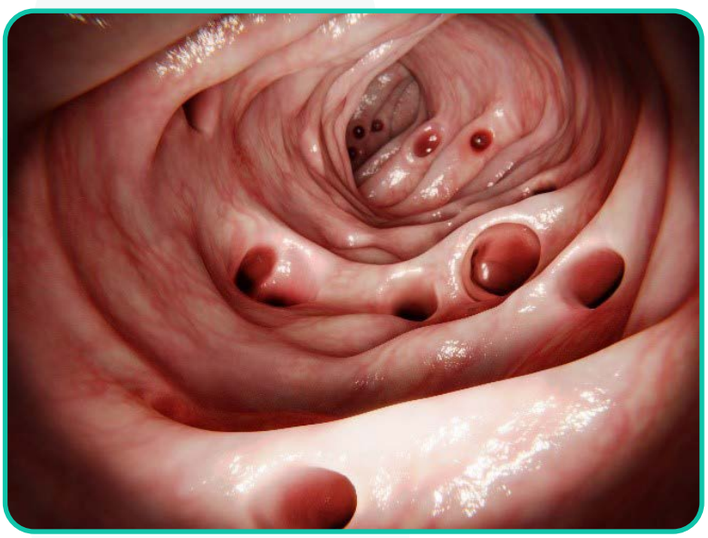
# 1.0 DIVERTICULITE AGUDA

## 1.1 INTRODUÇÃO

Um divertículo é definido como uma protrusão sacular da parede do cólon. Desenvolve-se em pontos de maior fraqueza, que correspondem ao local em que os vasos retos penetram na camada muscular circular do cólon. Um divertículo colônico típico é um pseudodivertículo ou divertículo "falso", no qual a mucosa e a submucosa “herniam” por meio da camada muscular, coberta apenas pela serosa.




Fonte: *Shutterstock*



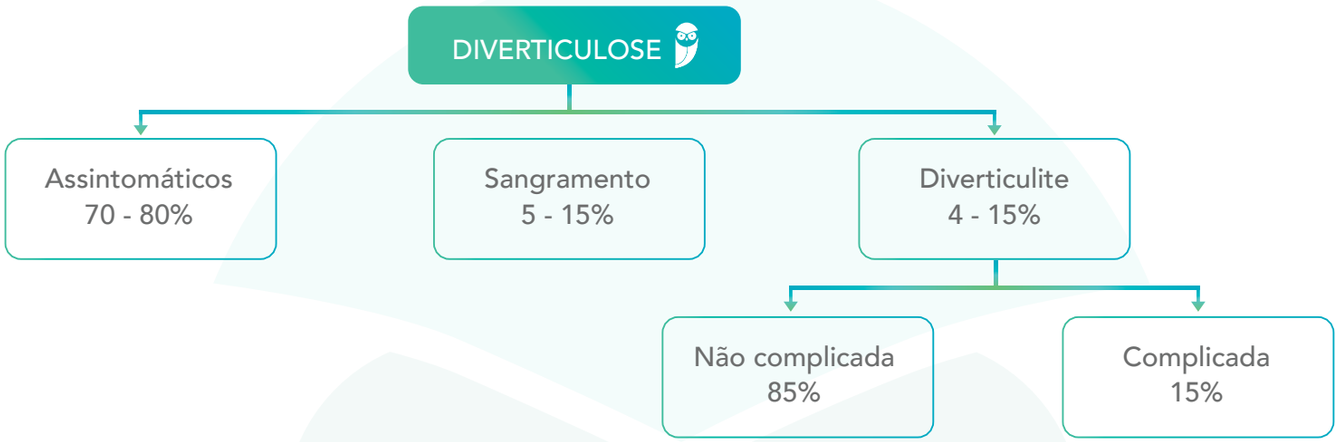
Colonoscopia evidenciando divertículos. Fonte: *Shutterstock*

A diverticulite aguda é definida como uma inflamação de um divertículo, geralmente associada à microperfuração.

## 1.2 EPIDEMIOLOGIA

A prevalência de diverticulose depende da idade, aumentando de menos de 20% aos 40 anos para 30% aos 60 anos e 60% a 80% após 80 anos. Aproximadamente 4% a 15% dos pacientes com diverticulose desenvolvem diverticulite, sendo que a incidência aumenta com a idade.

Abaixo dos 50 anos, a diverticulite é mais comum em homens; há uma ligeira predominância feminina entre as idades de 50 e 70 e acentuada acima dos 70 anos.




A distribuição da diverticulose no cólon varia de acordo com a geografia:

- ✓ Países ocidentais e industrializados: aproximadamente 95% dos pacientes têm divertículos no cólon sigmoide. A diverticulite aguda ocorre principalmente do lado esquerdo (72% sigmoide, 33% descendente, 3% cólon transverso e 5% do cólon ascendente). A diverticulite do lado direito (cecal) está presente em apenas 1,5% dos casos. A distribuição dos divertículos também pode variar de acordo com a raça, sendo que no cólon ascendente ou na flexão hepática é maior nos negros em comparação aos brancos (20% x 8%).
- ✓ Ásia: a diverticulose é predominantemente do lado direito, e a diverticulite à direita corresponde a 38% a 75% dos casos.

## 1.3 FISIOPATOLOGIA

São considerados fatores de risco da diverticulite:

- ✓ Alta ingestão alimentar de carne vermelha, baixa ingesta de fibra alimentar;
- ✓ Falta de atividade física;
- ✓ Obesidade;
- ✓ Tabagismo;
- ✓ Uso de vários medicamentos (por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides, esteroides e opiáceos); e
- ✓ Pacientes com síndromes de Ehler-Danlos, Marfan e Williams-Beuren, infecção pelo HIV.

**FATORES RELACIONADOS À FISIOPATOLOGIA DA FORMAÇÃO DE DIVERTÍCULOS**

- ✓ Aumento da pressão intraluminal.
- ✓ Alteração da motilidade intestinal.
- ✓ Modificação da estrutura colônica.
- ✓ Dieta pobre em fibras.

A causa subjacente da diverticulite é a perfuração microscópica ou macroscópica de um divertículo devido à inflamação diverticular e necrose focal.

A inflamação é geralmente leve, e uma pequena perfuração é comumente bloqueada por gordura pericólica e mesentérica. Isso pode levar a um abscesso localizado ou, se houver órgãos adjacentes, a uma fístula. Se a perfuração não for contida, pode ocorrer peritonite difusa.

# CAI NA PROVA

**(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 2022)** A prevalência da diverticulose tem aumentado tanto no ocidente quanto em países que adotaram um estilo de vida mais ocidental. A doença diverticular do cólon é uma causa importante de internações hospitalares. Vários fatores de estilo de vida têm sido associados à doença diverticular. Sobre essa doença, analise as afirmativas a seguir.

I. Alta ingestão de carne vermelha, dieta pobre em fibra alimentar e tabagismo estão associados ao risco de desenvolver doença diverticular.

II. Ao contrário da diverticulite, que ocorre principalmente no cólon esquerdo, o sangramento diverticular ocorre principalmente no cólon direito.

III. Existem evidências científicas robustas que apoiam o uso da mesalazina associado a probióticos para prevenir a recorrência de episódios de diverticulite.

Está correto o que se afirma em:




**A)** I e II, apenas.

**B)** I, apenas.

**C)** II e III, apenas.

**D)** I, II e III.

## COMENTÁRIOS

Vamos analisar as afirmativas.

**I. CORRETA**, pois são considerados fatores de risco para doença diverticular dos cólons:

- alta ingestão alimentar de carne vermelha, baixa ingesta de fibra alimentar;
- falta de atividade física;
- obesidade;
- tabagismo;
- uso de vários medicamentos (por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides, esteroides e opiáceos);
- pacientes com síndromes de Ehler-Danlos, Marfan e Williams-Beuren, infecção pelo HIV.

**II. CORRETA**: ao contrário da diverticulite, que ocorre principalmente no cólon esquerdo, o cólon direito é a fonte de sangramento diverticular colônico em 50 a 90% dos pacientes. Isso reflete um aumento acentuado na propensão para os divertículos do lado direito sangrarem, já que, nos países ocidentais, apenas 25% dos divertículos são do lado direito.

**III: INCORRETA**: em pacientes sem indicação de cirurgia, que serão observados, fazemos apenas modificações na dieta, que deve ser rica em fibras (> 30 gramas, se necessário suplementar) e no comportamento, como abolir o tabagismo e realizar atividades físicas, para diminuir o risco de recorrência futura. Não há consenso no uso de mesalazina, um anti-inflamatório com ação na mucosa intestinal, e outros agentes como antibióticos e probióticos.

Dessa forma, as afirmativas I e II estão corretas.

**Gabarito: alternativa A.**

**(SP - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - FMJ 2021)** A respeito da doença diverticular dos cólons, assinale a alternativa correta.

**A)** O uso de corticosteroides está associado ao maior risco de perfuração e complicações sépticas.

**B)** O número de relatos de casos de diverticulite está diminuindo em todo o mundo.

**C)** Na maior parte dos pacientes acometidos por essa doença, a presença de divertículos está associada à diminuição da pressão intraluminal dos cólons.

**D)** A ocorrência de diverticulite está associada à maior ingestão de grãos e sementes.

**E)** O reto é o local mais comum de aparecimento de divertículos adquiridos, logo em seguida, vem o sigmoide.

## COMENTÁRIO

**Correta a alternativa A:** uso crônico de corticoide leva à imunossupressão e há um maior risco de perfuração e, consequentemente, de complicações sépticas.

**Incorreta a alternativa B:** o número de relatos de casos de diverticulite não está diminuindo.

**Incorreta a alternativa C:** o aumento da pressão intraluminal está associado à fisiopatologia da doença diverticular.

**Incorreta a alternativa D:** a baixa ingesta de fibras está associada à fisiopatologia da doença diverticular.

**Incorreta a alternativa E:** o cólon sigmoide é o local mais acometido pela doença diverticular.

## 1.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A apresentação clínica da diverticulite aguda depende da gravidade do processo inflamatório subjacente e da presença de complicações associadas.

A dor abdominal é a queixa mais comum em pacientes com diverticulite aguda. A dor geralmente é constante e localizada no quadrante inferior esquerdo devido ao envolvimento frequente do cólon sigmoide. No entanto, os pacientes podem ter dor no quadrante inferior direito ou suprapúbica, devido à presença de um cólon sigmoide inflamado redundante, ou, menos frequentemente, diverticulite do lado direito.

Outros sintomas associados incluem febre baixa, anorexia, náuseas, vômitos, alteração do hábito intestinal com constipação (50%) e diarreia (25%). O paciente com diverticulite aguda pode apresentar distensão abdominal, pois o processo inflamatório intenso, ou mesmo a compressão por um abscesso localizado, pode estreitar a luz colônica e produzir uma obstrução parcial ou até total do cólon.

Aproximadamente 10% a 15% dos pacientes com diverticulite aguda apresentam urgência miccional, poliúria ou disúria devido à irritação da bexiga causada pela proximidade do cólon sigmoide inflamado.

A instabilidade hemodinâmica com taquicardia, hipotensão e choque é rara e está associada à perfuração livre e peritonite difusa.




**APRESENTAÇÃO CLÍNICA DA DIVERTICULITE AGUDA**

- ✓ Dor abdominal em quadrante inferior esquerdo;
- ✓ Náuseas, vômitos e febre baixa; e
- ✓ Alteração do hábito intestinal: constipação ou diarreia.

No exame físico, podemos palpar uma massa dolorosa em quadrante inferior esquerdo devido à inflamação ou abscesso peridiverticular. Os pacientes podem ter sinais peritoneais localizados, com defesa muscular e descompressão brusca positiva. O exame retal pode revelar massa ou sensibilidade à palpação na presença de um abscesso pélvico ou no sigmoide distal.

# CAI NA PROVA

**(AMRIGS 2018)** Paciente de 56 anos, sexo masculino, obeso e diabético. Chega à UPA com quadro de dor abdominal em fossa ilíaca esquerda e parada de eliminação de gazes e fezes há 48 horas. Refere já ter tido outros episódios semelhantes previamente. Ao exame, o abdome encontra-se distendido e com dor à palpação em fossa ilíaca esquerda. TAX de 36,8°C e pressão arterial de 160 x 110 mmHg. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

**A)** Gastroparesia diabética.
**B)** Apendicite aguda.
**C)** Úlcera perfurada.
**D)** Pancreatite aguda.
**E)** Diverticulite aguda.

## COMENTÁRIO

Sempre que tivermos um paciente com dor em FIE devemos pensar em diverticulite aguda. Ele ainda tem relato de episódios anteriores e apresenta parada de eliminação de gazes e fezes há dois dias, ou seja, sinais de obstrução intestinal, que é uma das complicações da diverticulite.

**Incorreta a alternativa A:** a gastroparesia diabética apresenta-se com náuseas, vômitos, dor abdominal epigástrica (e não em FIE), saciedade precoce, plenitude pós-prandial e distensão do andar superior do abdome.
**Incorreta a alternativa B:** a dor da apendicite aguda é na fossa ilíaca direita! E não é comum cursar com obstrução intestinal.
**Incorreta a alternativa C:** aqui teríamos um quadro mais agudo, com dor epigástrica súbita associada à peritonite difusa, com abdome em tábua e descompressão brusca positiva.
**Incorreta a alternativa D:** pancreatite aguda normalmente apresenta-se com dor epigástrica, em faixa, no abdome superior e com irradiação para o dorso, associada a náuseas e vômitos.
**Correta a alternativa E** quadro clínico clássico de diverticulite aguda, com dor em FIE, alterações intestinais e relato de episódiosprévios do mesmo quadro.

---

**(SCMM – 2017)** A respeito da doença diverticular dos cólons e diverticulite, aponte a alternativa INCORRETA.

**A)** O Cólon sigmoide é o local mais cometido, e a segunda área mais envolvida é o cólon descendente.
**B)** São divertículos verdadeiros, pois são formados por todas as camadas da parede do intestino.
**C)** Segundo a classificação de Hinchey para diverticulite, estádio II, corresponde ao abscesso pélvico bloqueado, e o tratamento de escolha é drenagem percutânea via tomografia computadorizada ou ultrassom.
**D)** Nas peritonites generalizadas causadas pela diverticulite e associadas à sepse, não é seguro restabelecer continuidade intestinal, pela elevada probabilidade de cicatrização inadequada. Nesse caso, a operação apropriada é a cirurgia de Hartmann.

## COMENTÁRIO

**Correta a alternativa A:** nos países ocidentais e industrializados, a diverticulite aguda ocorre principalmente do lado esquerdo (72% sigmoide, 33% descendente, 3% cólon transverso e 5% do cólon ascendente). A diverticulite do lado direito (cecal) está presente em apenas 1,5% dos casos.

**Incorreta a alternativa B.** Um divertículo colônico típico é um divertículo "falso", no qual a mucosa e a submucosa herniam por meio da camada muscular, coberta apenas pela serosa.

**Correta a alternativa C:** ainda vamos falar sobre a classificação de Hinchey e o tratamento da diverticulite aguda. Mas, para você entender a questão:

Estágio I: abscesso mesentérico ou pericólico pequeno, confinado;

Estágio II: abscesso pélvico bloqueado;

Estágio III: peritonite purulenta generalizada; e

Estágio IV: peritonite fecal generalizada.

O tratamento da diverticulite Hinchey II é drenagem percutânea (se o abscesso for ≥ 4 cm) e antibioticoterapia endovenosa.

**Correta a alternativa D:** mesmo que não tenhamos falado sobre o tratamento da diverticulite, sempre que estivermos diante de um abdome agudo com peritonite difusa, não é aconselhável realizar anastomoses intestinais pelo risco de deiscência. Na diverticulite aguda com peritonite difusa, purulenta ou fecal, o tratamento de escolha é a cirurgia de Hartmann. Essa consiste na ressecção do segmento afetado, colostomia terminal proximal e fechamento do coto retal distal.

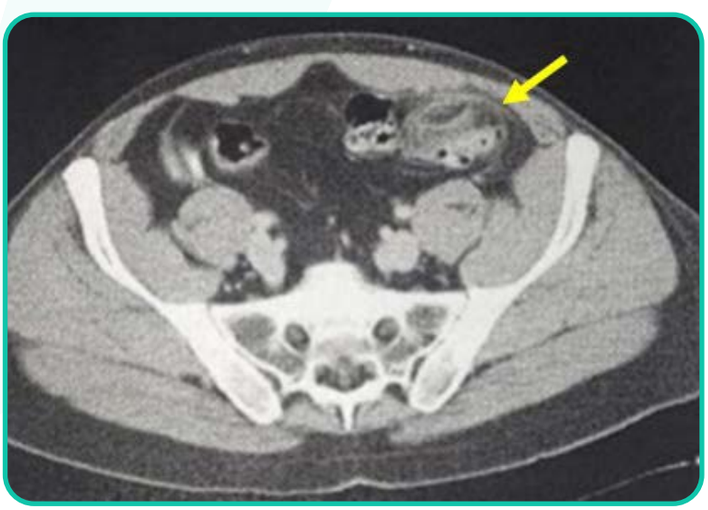
## 1.5 COMPLICAÇÕES

Aproximadamente 15% dos pacientes com diverticulite aguda têm complicações agudas e podem necessitar de drenagem ou cirurgia para o tratamento.

### ABSCESSO

**É a complicação mais comum**, ocorrendo em aproximadamente 17% dos pacientes hospitalizados com diverticulite aguda. Um abscesso diverticular pode ser observado na tomografia abdominal na apresentação inicial ou pode desenvolver-se posteriormente. Portanto, deve-se suspeitar de abscesso diverticular em pacientes com diverticulite não complicada que não apresentam melhora da dor abdominal ou febre persistente, apesar do início do tratamento com antibióticos.





## ABSCESSO É A COMPLICAÇÃO MAIS COMUM DA DIVERTICULITE AGUDA.

### OBSTRUÇÃO

Pode ocorrer obstrução colônica parcial, ou até total, devido ao estreitamento da luz pela inflamação pericolônica ou compressão de um abscesso diverticular, que geralmente se resolve com o tratamento da diverticulite. Pode ocorrer obstrução do intestino delgado por aderência ao fleimão ou abscesso. Nesses casos, além do tratamento da diverticulite com antibióticos e drenagem percutânea do abscesso (se ≥ 4 cm), é necessária a passagem de sonda nasogástrica para descompressão intestinal.

A obstrução decorrente da formação de estenose não é comum, mas pode ocorrer, pois a inflamação crônica resulta em estreitamento da luz intestinal. Mesmo sendo uma obstrução parcial na maioria dos casos, os pacientes podem desenvolver sintomas significativos, com necessidade de tratamento cirúrgico **eletivo.**

### FÍSTULA

A inflamação da diverticulite aguda pode resultar na formação de uma fístula entre o cólon e as vísceras adjacentes. Os tipos mais comuns são as **FÍSTULAS COLOVESICAIS** (65%), colovaginais (25%), coloentéricas (7%), colouterinas (3%) e colocutâneas. A fístula colovesical é mais comum nos homens (2-3:1), provavelmente devido à proteção uterina (atenção às mulheres histerectomizadas!). A cúpula vesical é o local mais comum da fístula.

**CLÍNICA:** pacientes com fístula colovesical costumam apresentar infecções urinárias de repetição, pneumatúria, fecalúria ou disúria. Pacientes com fístula colovaginal podem relatar passagem de fezes ou flatos pela vagina.

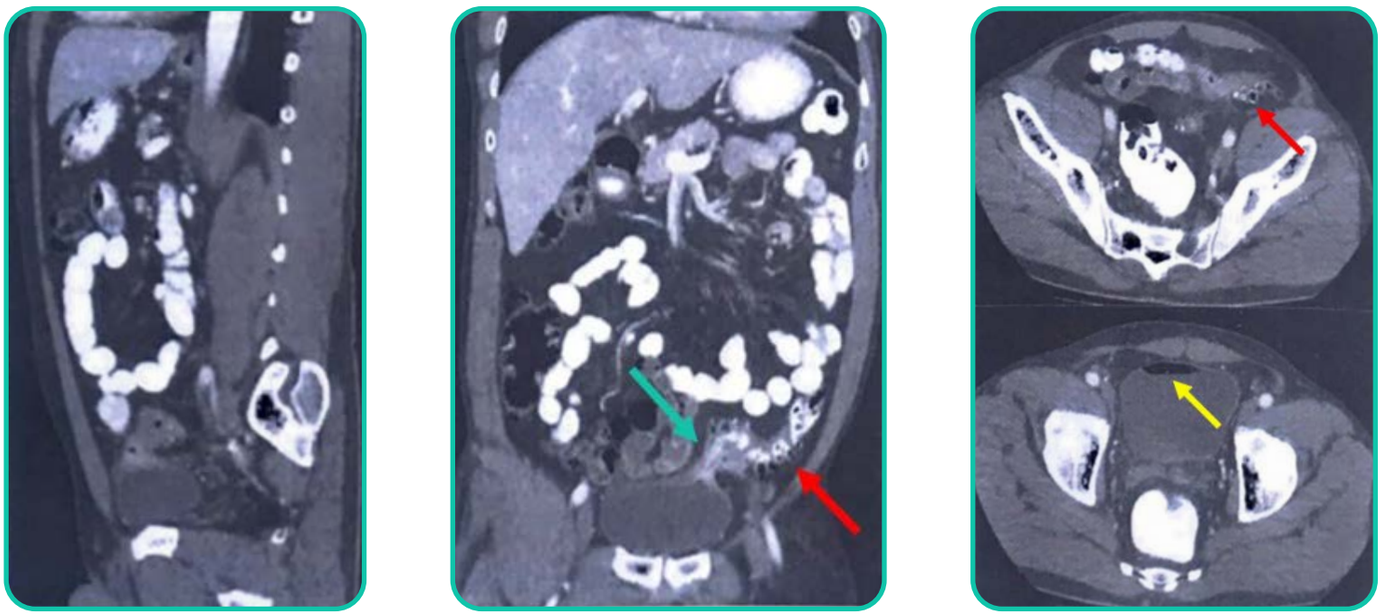
**DIAGNÓSTICO**: normalmente é feito por meio de uma tomografia com contraste oral e retal, em que é visualizado ar dentro da bexiga, sem histórico de manipulação prévia. Esse é um sinal patognomônico de fístula colovesical. Um enema de bário pode revelar uma fístula colovesical em até 50% dos casos. Na cistoscopia, é possível visualizar cistite e um edema bolhoso no local da fístula.

A colonoscopia pode não visualizar diretamente a fístula, mas permite um melhor estudo do cólon em busca de neoplasias e da doença de Crohn, que também são causas de fístula colovesical.



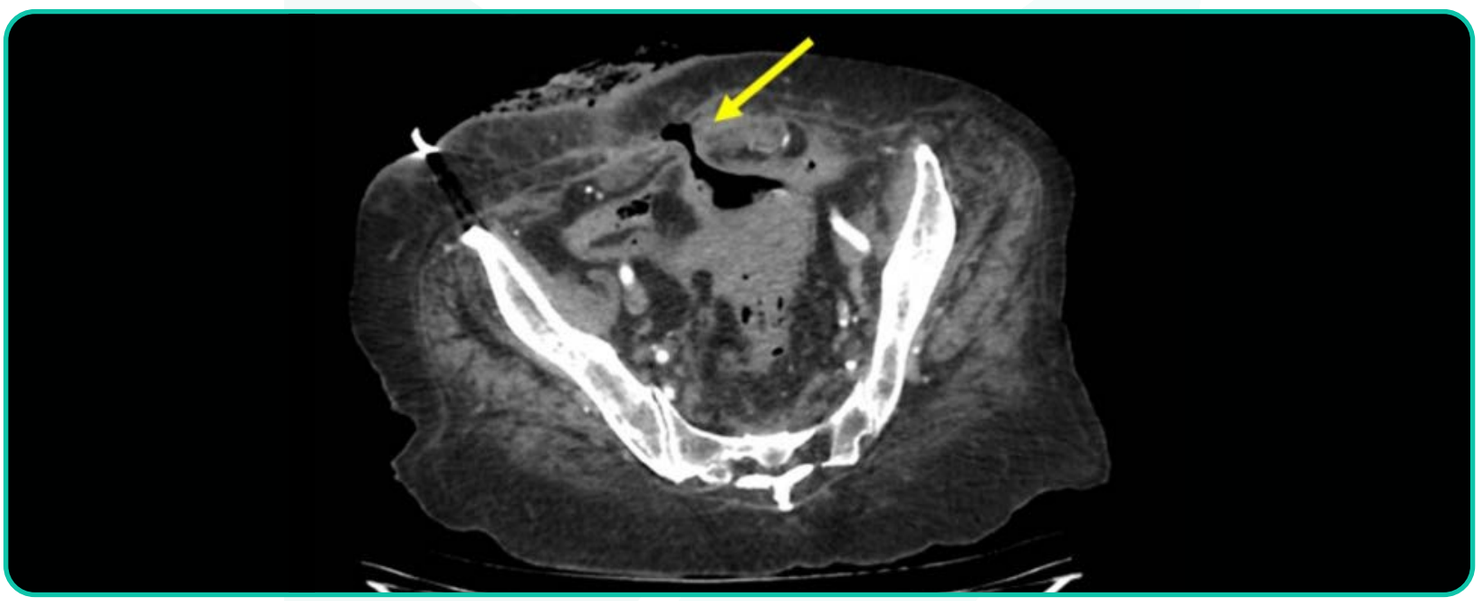

**CAUSAS DE FÍSTULA COLOVESICAL**

- ✓ Diverticulite: 65% a 79%;
- ✓ Neoplasia colorretal: 10% a 20% dos casos; e
- ✓ Doença de Crohn: 5% a 7%.



**Setas vermelhas:** divertículos no sigmoide
**Seta amarela:** ar no interior da bexiga
**Seta verde:** fístula colovesical

Diverticulite com fístula colovesical. Fonte: Prova de acesso direto USP, 2021.



Fístula colecistocutânea. Fonte: Acervo pessoal.

**TRATAMENTO**: o tratamento inicial da fístula colovesical consiste em controle da infecção com antibioticoterapia e cirurgia eletiva posteriormente, ou seja, sigmoidectomia com anastomose primária e fechamento da fístula. Geralmente, devemos manter sondagem vesical de demora por pelo menos 7 dias após a cirurgia. Não esquecer de solicitar colonoscopia previamente à cirurgia para excluir outras causas da fístula, por exemplo, neoplasias.

### PERFURAÇÃO

A perfuração com peritonite generalizada pode resultar da ruptura de um abscesso diverticular na cavidade peritoneal (peritonite purulenta) ou da ruptura livre de um divertículo inflamado com contaminação fecal do peritônio (peritonite fecal). Embora apenas 1% a 2% dos pacientes com diverticulite aguda tenham perfuração com peritonite purulenta ou fecal, as taxas de mortalidade aproximam-se de 20%. Clinicamente, apresentam-se com dor abdominal difusa, defesa muscular e descompressão brusca positiva. Os ruídos hidroaéreos geralmente estão ausentes, devido ao íleo.

### ABSCESSO HEPÁTICO PIOGÊNICO

É raro e ocorre devido à disseminação da infecção pela circulação portal.

### ESTENOSE COLÔNICA

Ocorre devido a ataques recorrentes de diverticulite ou inflamação diverticular crônica persistente. Pacientes podem evoluir com obstrução colônica aguda sem diverticulite ou com sintomas mais insidiosos de dor abdominal e constipação. Geralmente necessitam de tratamento cirúrgico eletivo.

## CAI NA PROVA

**(GO - HOSPITAL DE OLHOS APARECIDA - HOA 2023)** O principal tip(o de fístula associada à complicação da diverticulite aguda é:

**A)** enterocolônica.
**B)** colocutânea.
**C)** colovesical.
**D)** colovaginal.

## COMENTÁRIO

A diverticulite aguda pode complicar com a formação de uma fístula entre o cólon e as vísceras adjacentes. Os tipos mais comuns são as fístulas colovesicais (65%), colovaginais (25%), coloentéricas (7%), colouterinas (3%) e colocutâneas.

**Correta a alternativa C.**

**(SP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP - 2022 - DISCURSIVA)** Homem, 70a, refere episódios de infecção urinária há um ano. Apresenta quadro de pneumatúria e fecalúria há 30 dias. A PRINCIPAL ETIOLOGIA DETERMINANTE DESSA CONDIÇÃO É:

## COMENTÁRIO

Sempre que estivermos diante de um paciente com fecalúria (saída de fezes pela urina) e pneumatúria, devemos ter como hipótese diagnóstica uma fístula colovesical, cuja principal causa é a diverticulite aguda.

As principais causas de fístula colovesical são:

- diverticulite, 65 a 79%;
- neoplasia colorretal, 10 a 20% dos casos;
- doença de Crohn, 5 a 7%.

**Gabarito: diverticulite aguda do cólon sigmoide.**

---

**UNICAMP 2018)** Mulher 58a, com dor em fossa ilíaca esquerda e baixo ventre há sete dias e dor miccional, disúria e saída de ar no final da micção há três dias. Antecedentes pessoais: histerectomia há 15 anos e tabagismo 10 maços/ano. A causa dessa condição é:

**A)** Doença de Crohn no ângulo de Treitz.
**B)** Câncer de colo uterino remanescente.
**C)** Câncer de bexiga com invasão do trígono.
**D)** Diverticulite complicada de cólon.

## COMENTÁRIO

Temos uma paciente com dor em FIE (já pensamos em diverticulite!), associada a sintomas urinários, como dor miccional, disúria e PNEUMATÚRIA (saída de ar durante a micção). Outro dado importante é que a paciente é histerectomizada, ou seja, o cólon sigmoide tem contato direto com a bexiga.

Estamos diante de uma provável fístula colovesical. Vamos às alternativas:

**Incorreta a alternativa A:** a doença de Crohn é uma das causas pouco frequentes de fístula colovesical (5% a 7% dos casos), mas não no ângulo de Treitz, que fica na região epigástrica/mesogástrica.

**Incorreta a alternativa B:** porque câncer de colo uterino não apresenta como sintomas dor em fossa ilíaca esquerda nem pneumatúria. Pode apresentar dor local e sangramento vaginal.

**Incorreta a alternativa C:** porque câncer de bexiga apresenta como sintoma principal a hematúria. Pode ser uma das causas de fístula colovesical, mas não é a mais comum.

**Correta a alternativa D** Porque a causa mais comum da fístula colo vesical é a diverticulite aguda (65% a 79% dos casos) e, em uma paciente, tabagista, histerectomizada, com queixa de dor em FIE, é o diagnóstico mais provável. O próximo passo será realizar uma tomografia de abdome e pelve para confirmar esse diagnóstico.

## 1.6 EXAMES COMPLEMENTARES

### 1.6.1 LABORATÓRIO

Leucocitose e aumento da PCR são comuns. Pode haver aumento da amilase e lipase.

Leucocitúria é possível pela proximidade do cólon sigmoide com a bexiga. Se houver cultura positiva para a flora colônica, devemos pensar em fístula colovesical.

---

### 1.6.2 EXAMES DE IMAGEM

A imagem abdominal é necessária para estabelecer o diagnóstico de diverticulite aguda.

#### RADIOGRAFIAS SIMPLES DE ABDOME E TÓRAX

As alterações geralmente estão presentes nas complicações, como obstrução (dilatação de alças e níveis hidroaéreos) e perfuração intestinal (pneumoperitônio).

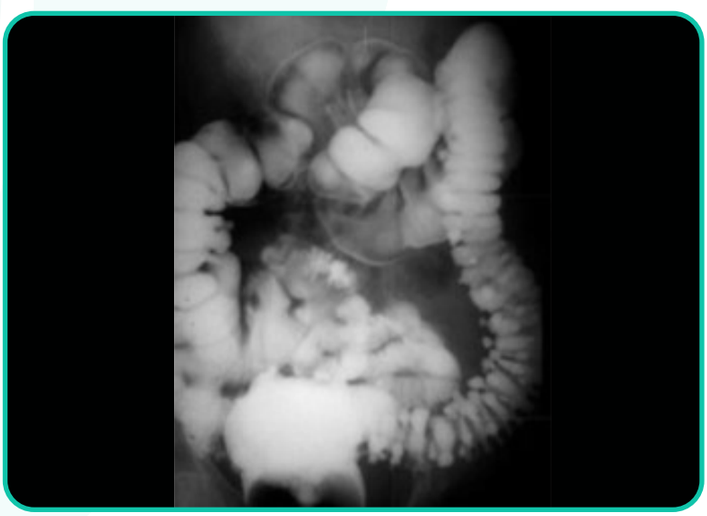
#### ENEMA

O enema opaco confere informações a respeito da extensão da doença diverticular, da gravidade de eventuais estenoses existentes, da presença de abscessos e fístulas. Muito se discute sobre o momento adequado de realizá-lo em pacientes com quadro clínico de diverticulite, pois há relatos na literatura de peritonites eclodidas pela realização de enemas opacos, que desbloquearam perfurações diverticulares até então contidas por bloqueio aderencial de vísceras adjacentes. As peritonites por fezes, pus e bário assim formadas são extremamente letais. Para contornar tal perigo, alguns centros utilizam contraste hidrossolúvel para a realização imediata de enemas contrastados em pacientes com diagnóstico de doença diverticular complicada. O contraste hidrossolúvel, caso ocorra desbloqueio da perfuração diverticular, é muito menos pernicioso do que o bário.

Com o advento da tomografia, o enema praticamente foi abandonado para o diagnóstico da diverticulite. É contraindicado na suspeita de perfuração e, se for realizado, deve ser com contraste hidrossolúvel.




Enema: doença diverticular do cólon sigmoide. Fonte: *Shutterstock*



Doença diverticular. Fonte: Prova de acesso direto UFCG, 2017.

### TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

**É O EXAME PADRÃO-OURO PARA O DIAGNÓSTICO DE DIVERTICULITE AGUDA.** A sensibilidade e especificidade da TC abdominal com contraste oral e intravenoso para o diagnóstico de diverticulite aguda são de 94% e 99%, respectivamente. Tem a vantagem de excluir outras patologias abdominais. Os principais achados sugestivos de diverticulite aguda incluem:

- ✓ Presença de espessamento localizado da parede intestinal (> 4 mm);
- ✓ Aumento na densidade de tecidos moles na gordura pericolônica secundária à inflamação ou borramento de gordura;
- ✓ Presença de divertículos; e
- ✓ Identificação das complicações: abscessos, sinais de obstrução intestinal (dilatação de alças com níveis hidroaéreos), líquido livre na cavidade (peritonite difusa) e pneumoperitônio.

### ULTRASSONOGRAFIA

A ultrassonografia de alta resolução tem sensibilidade e especificidade semelhantes às da tomografia computadorizada. O ultrassom também tem a vantagem de ser amplamente disponível, barato e evitar a exposição à radiação. No entanto, depende do examinador, apresenta limitações em pacientes obesos e na presença de distensão abdominal e não pode excluir outras causas de dor abdominal.

### COLONOSCOPIA

**NÃO ESTÁ INDICADA** para o diagnóstico de diverticulite aguda, pois a inflamação é peridiverticular, além de ser um risco para perfuração ou exacerbação da inflamação existente no quadro agudo.

Após a resolução completa dos sintomas associados à diverticulite aguda, é realizada uma colonoscopia para exclusão de malignidade associada, geralmente em seis a oito semanas.

## CAI NA PROVA

**(SP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - SCMMA 2023)** Dos testes de imagem, o que apresenta maior acurácia em uma diverticulite aguda não complicada é:

**A)** radiografia de abdome agudo.
**B)** enema opaco.
**C)** tomografia computadorizada.
**D)** colonoscopia.

## COMENTÁRIOS

**Incorreta a alternativa A:** a radiografia de abdome agudo não confirma o) diagnóstico de diverticulite aguda.
**Incorreta a alternativa B:** o enema opaco não é utilizado rotineiramente para o diagnóstico de diverticulite aguda, além de ter acurácia inferior à tomografia.
**Correta a alternativa C:** a tomografia é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de diverticulite aguda, complicada ou não complicada.
**Incorreta a alternativa D:** *a* colonoscopia está contraindicada para o diagnóstico de diverticulite pelo risco de "desbloqueio" de uma perfuração bloqueada.

**(MT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO - UFMT (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER - HUJM) 2023)** Homem de 61 anos apresenta quadro de dor em quadrante inferior esquerdo do abdome há 4 dias, associado à febre (temperatura axilar de 38,1 ºC) e episódios de diarreia, sem muco ou sangue. Refere também indisposição e hiporexia nesse período. Ao exame físico abdominal, encontra-se dor à palpação superficial e profunda, massa palpável em fossa ilíaca esquerda. O hemograma apresenta leucocitose e o exame de urina não evidencia alterações significativas. Diante do quadro, que exame deve ser solicitado nesse momento para confirmação diagnóstica?

**A)** Tomografia computadorizada de abdome total.
**B)** Colonoscopia.
**C)** Enema opaco.
**D)** Ultrassonografia de abdome total.

## COMENTÁRIOS

**Correta a alternativa A.**

**(RS - ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL - AMRIGS 2018)** Paciente de 56 anos, sexo masculino, obeso e diabético. Chega à UPA com quadro de dor abdominal em fossa ilíaca esquerda e parada de eliminação de gazes e fezes há 48 horas. Refere já ter tido outros episódios semelhantes previamente. Ao exame, o abdome encontra-se distendido e com dor à palpação em fossa ilíaca esquerda. TAX de 36,8°C e pressão arterial de 160x110 mmhg.

No caso acima, o exame diagnóstico com maior especificidade que pode ser reailzado é:

**A)** Ecografia abdominal total.
**B)** Tomografia computadorizada de abdome.
**C)** Raio-x de abdome agudo.
**D)** Cintilografia abdominal.
**E)** Colonoscopia.

## COMENTÁRIOS

Temos um paciente com quadro clínico clássico de diverticulite aguda. Ele apresenta dor em FIE, alterações do hábito intestinal e relato de episódios prévios do mesmo quadro. E, diante de uma suspeita de diverticulite aguda, a confirmação diagnóstica faz-se por meio da tomografia de abdome e pelve contrastada (endovenoso e oral), com sensibilidade e especificidade de 94% e 99%, respectivamente.

Vale lembrar que não devemos realizar colonoscopia nesses pacientes, pelo risco de perfuração ou mesmo de aumentar uma perfuração já existente e que esteja bloqueada e causar uma peritonite difusa, principalmente diante de sintomas de obstrução intestinal. A ultrassonografia não será um exame útil devido à distensão gasosa, e a radiografia de abdome agudo pode mostrar-nos sinais de obstrução intestinal, mas não o diagnóstico de diverticulite.

A radiografia de abdome agudo não apresenta sinais específicos que confirmem o diagnóstico de diverticulite.

**Correta a alternativa B.**

## 1.7 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

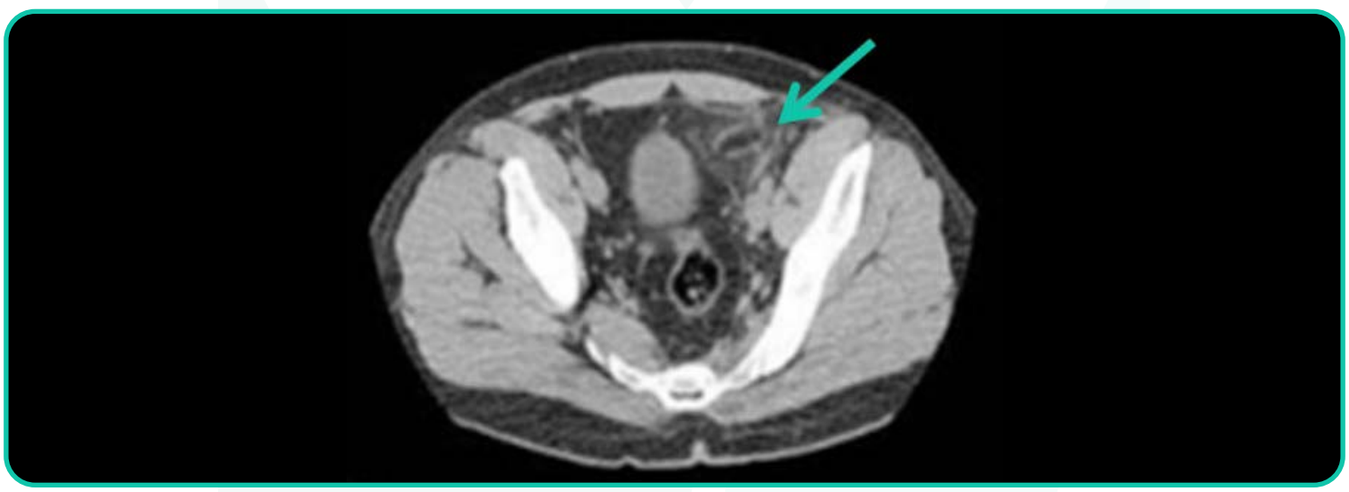
A diverticulite aguda pode ser diferenciada da maioria das outras causas de dor abdominal inferior com base nas características clínicas, exame físico, estudos laboratoriais e tomografia abdominal.

## DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

**Síndrome do intestino irritável (SII) –** os sintomas de dor abdominal e hábitos intestinais alterados com constipação ou diarreia são crônicos em pacientes com SII. A tomografia computadorizada é normal em pacientes com SII.

**Câncer colorretal –** pacientes com câncer colorretal (CCR) podem apresentar características clínicas semelhantes às da diverticulite e espessamento da parede intestinal na TC abdominal. No entanto, a presença de inflamação pericolônica e mesentérica, envolvimento superior a 10 cm de extensão do cólon e ausência de linfonodos pericolônicos aumentados na TC abdominal sugerem diverticulite aguda. Em 10% a 20% dos pacientes, ainda é difícil distinguir entre diverticulite aguda e um carcinoma colorretal na tomografia computadorizada abdominal, e uma neoplasia só pode ser excluída com uma colonoscopia após a resolução da inflamação aguda.

**Apendagite** – é uma condição clínica incomum, benigna e autolimitada. Resulta da torção ou trombose venosa espontânea das veias que drenam os apêndices epiplóicos. Manifesta-se por dor abdominal aguda localizada principalmente em quadrante inferior esquerdo (60 a 80%), sem febre e alterações laboratoriais. O diagnóstico faz-se por tomografia computadorizada de abdome, que mostra imagem ovalar, com densidade de gordura e centro radioluscente. O tratamento é conservador, com analgésicos e anti-inflamatórios e há melhora completa dos sintomas em torno de 3 a 14 dias.



Apendagite. Fonte: Prova de acesso direto HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA (HOS 2019)

**Apendicite aguda** – os sintomas clássicos da apendicite incluem dor abdominal no quadrante inferior direito, anorexia, febre, náusea e vômito. A dor abdominal é inicialmente periumbilical e subsequentemente no quadrante inferior direito. Pacientes com o cólon sigmoide redundante ou diverticulite do cólon direito (mais comum nos asiáticos) apresentam sintomatologia bem semelhante à apendicite. No entanto, a tomografia computadorizada abdominal tem importante papel nessa diferenciação.

**Doença inflamatória intestinal** – em pacientes com doença inflamatória intestinal (DII), a diarreia, e não a dor abdominal, é o sintoma predominante. Além disso, os pacientes apresentam sintomas por vários meses antes da apresentação. Embora a tomografia computadorizada de abdome possa demonstrar espessamento da parede tanto na diverticulite aguda quanto na DII, a presença de diverticulose e inflamação peridiverticular são sugestivas de diverticulite aguda.

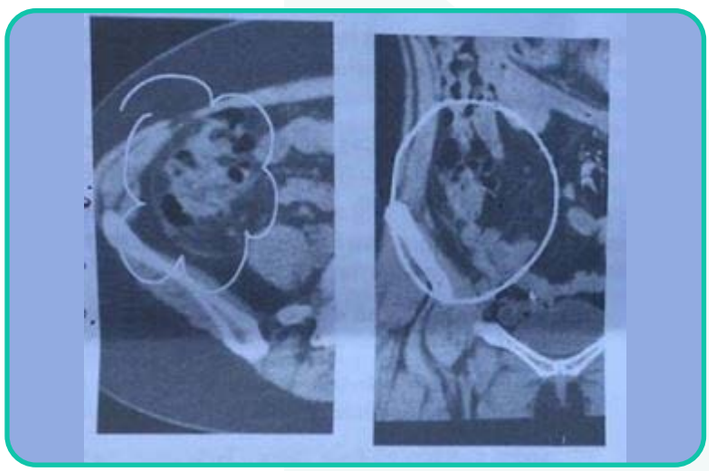
**Colite infecciosa** – em pacientes com colite infecciosa, a diarreia é o sintoma predominante. Os pacientes podem ter um histórico de uso prévio de antibióticos ou viagens recentes. As culturas de fezes podem identificar o patógeno causador. A tomografia abdominal pode demonstrar espessamento da parede na colite infecciosa, mas não uma inflamação peridiverticular.

**Colite isquêmica** – pacientes com colite isquêmica geralmente apresentam rápido início de dor abdominal à esquerda, hematoquezia ou diarreia mucossanguinolenta. Os pacientes podem ter fatores de risco para colite isquêmica (por exemplo, idade> 60 anos, hemodiálise, hipertensão, diabetes mellitus, desidratação ou uso de laxante). Na tomografia computadorizada do abdome, pode ser observado espessamento segmentar da parede intestinal, semelhante aos pacientes com diverticulite aguda, mas a inflamação pericolônica está ausente.

**Outros** – diagnósticos alternativos também devem ser considerados no diagnóstico diferencial de diverticulite aguda. Esses incluem abscesso tubo-ovariano, cisto ovariano, torção ovariana, gravidez ectópica, cistite e nefrolitíase.

## CAI NA PROVA

**(IAMSPE 2020)** Paciente de 42 anos, feminina e oriental, apresenta dor abdominal em fossa ilíaca direita. Tem descompressão brusca positiva no local. Está em estado geral bom, não toxemiada e hemograma de 10 mil leucócitos por mL, proteína C reativa discretamente elevada. Realizou a tomografia a seguir. Em princípio, baseado no diagnóstico, a conduta mais adequada é:



**A)** Tratamento com antibiótico e analgesia.
**B)** Apendicectomia por videolaparoscopia.
**C)** Colectomia por vídeo.
**D)** Apendicectomia após um mês.
**E)** Videolaparoscopia diagnóstica.

### COMENTÁRIO

Questão bem interessante e fácil de errar! Em paciente com dor em FID e descompressão brusca positiva, a primeira hipótese que nos vem em mente é a apendicite aguda, principal causa de abdome agudo! Mas, o enunciado tem dois pontos-chaves: a paciente é oriental, o que não quer dizer que ela não possa ter uma apendicite, mas reforça o diagnóstico diferencial de uma diverticulite de cólon direito (ceco), que é mais comum nos pacientes asiáticos e mais jovens. Além disso, o autor dá-nos uma imagem tomográfica que nos mostra alguns focos gasosos pericolônicos, borramento da gordura, porém sem identificação de imagem clássica de apendicite (imagem tubuliforme, com espessamento de parede, presença de fecalito...). Desse modo, fechamos o diagnóstico de uma diverticulite de cólon direito. Agora a questão nos pede o tratamento!

**Correta a alternativa A** O tratamento da diverticulite aguda não complicada (reparem na imagem que não há abscessos) em uma paciente clinicamente bem é ambulatorial, com antibióticos por 7 a 10 dias, analgésicos e uma dieta líquida e sem resíduos, e reavaliação em 2-3 dias. Calma, ainda falaremos sobre o tratamento da diverticulite de cólon direito!

**Incorreta a alternativa B:** esse seria o tratamento da apendicite aguda não complicada.

**Incorreta a alternativa C:** a ressecção intestinal (colectomia) diante de uma diverticulite está indicada se houver peritonite difusa (não é o caso da nossa paciente, que não está toxemiada) e geralmente é realizada por laparotomia mediana, apesar de a laparoscopia não ser contraindicação.

**Incorreta a alternativa D:** a apendicectomia de intervalo é realizada nos casos de apendicite complicada com abscesso periapendicular, após tratamento com drenagem percutânea e antibioticoterapia, e realização de colonoscopia após 6 a 8 semanas do tratamento.

**Incorreta a alternativa E:** já temos o diagnóstico de diverticulite de cólon direito. Não é necessária uma laparoscopia diagnóstica.

---

**(HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA - HOS 2019)** Homem, 34 anos, procura o pronto-socorro com queixa de dor em quadrante inferior esquerdo do abdome há 3 dias. Nega diarreia, febre e quadros semelhantes anteriores. Ao exame físico, nota-se dor em região de flanco e fossa ilíaca esquerda. Exames laboratoriais mostram leucocitose de 12000 células/mm³, sem desvio à esquerda, PCR (proteína C reativa), ureia, creatinina e provas de função hepática normais. A tomografia computadorizada do abdome mostra imagem ovalar medindo 3,2 cm, com densidade de gordura e centro radioluscente. Uma imagem da tomografia é apresentada a seguir. Face ao exposto, assinale a alternativa que indica corretamente o diagnóstico e o tratamento.



**A)** Diverticulite aguda; antibioticoterapia.

**B)** Diverticulite de Meckel; ressecção cirúrgica.

**C)** Apendagite epiploica; analgésicos e anti-inflamatórios.

**D)** Cálculo ureteral esquerdo; retirada e passagem de cateter tipo duplo J.

**E)** Obstrução intestinal; jejum, sonda nasogástrica e hidratação endovenosa.

## COMENTÁRIOS

Temos um paciente jovem com dor em quadrante inferior esquerdo. Até poderíamos pensar em uma diverticulite aguda, mas a faixa etária mais comum da diverticulite é após 50 anos de idade; além disso o paciente não apresenta febre, leucocitose e aumento da PCR. A tomografia apresentada não evidencia a presença de divertículos colônicos.

**Incorreta a alternativa A:** a diverticulite aguda normalmente acomete pacientes mais idosos e **geralmente está associada à febre e leucocitose.** O melhor método diagnóstico é a tomografia de abdome com contraste. O tratamento sempre se faz com antibioticoterapia, e a necessidade de intervenção cirúrgica depende da presença ou não de complicações.

**Incorreta a alternativa B:** o divertículo de Meckel é um remanescente congênito do ducto onfalomesentérico e está localizado no intestino delgado, a aproximadamente um metro da válvula ileocecal. Geralmente, é assintomático, mas pode causar quadro semelhante a um abdome agudo inflamatório quando inflamado. Devemos estar atentos a esse diagnóstico em crianças pré-escolares. A imagem tomográfica apresentada não evidencia um divertículo de Meckel.

**Correta a alternativa C** A apendagite é uma condição que resulta da torção ou trombose venosa espontânea das veias que drenam os apêndices epiplóicos. Manifesta-se por dor abdominal aguda localizada principalmente em quadrante inferior esquerdo (60% a 80%), mas pode ocorrer à direita e simular uma apendicite, **sem febre e alterações laboratoriais.** O diagnóstico faz-se por tomografia computadorizada de abdome, que demonstra uma formação ovalar com centro radioluscente pericolônico, como na imagem apresentada.

**Incorreta a alternativa D:** cálculo ureteral geralmente apresenta dor de forte intensidade em região lombar e/ou flanco. Além disso, a imagem de 3,2 cm não é compatível com um cálculo ureteral.

**Incorreta a alternativa E:** nosso paciente não apresenta um quadro clínico sugestivo de obstrução intestinal, que seria dor e distensão abdominal, vômitos, parada de eliminação de fezes e flatos. A tomografia apresentada também não evidencia nenhum indício de obstrução intestinal.

## 1.8 TRATAMENTO

Com base nos achados da história, exame físico e tomografia computadorizada, os pacientes são submetidos à avaliação para receber tratamento hospitalar ou ambulatorial de acordo com a presença ou não de complicações.

Antes de falarmos sobre o tratamento da diverticulite aguda, é primordial sabermos a CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY. Essa classificação é feita a partir de exames tomográficos e orienta-nos qual é a melhor conduta.

### 1.8.1 CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY

Meu querido aluno, se for para escolher o que você tem que saber sobre a diverticulite, é essa **classificação de Hinchey**. Com certeza é o que mais cai em prova sobre esse tema! Vamos aprender?

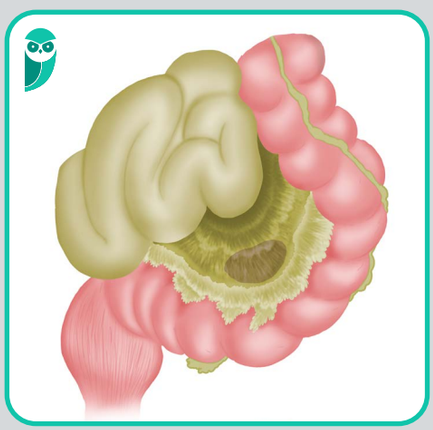
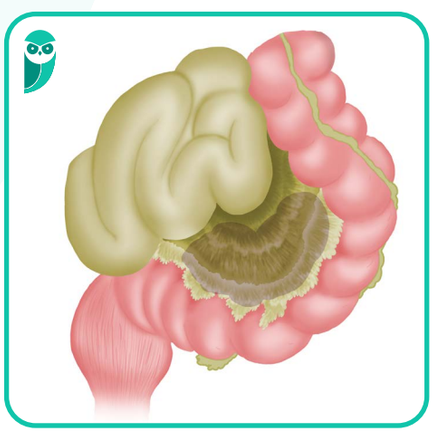
A classificação de Hinchey, de 1978, divide a diverticulite aguda em quatro estágios e é utilizada para descrever a gravidade da **doença diverticular complicada por perfuração**, além de servir como um guia para o tratamento.

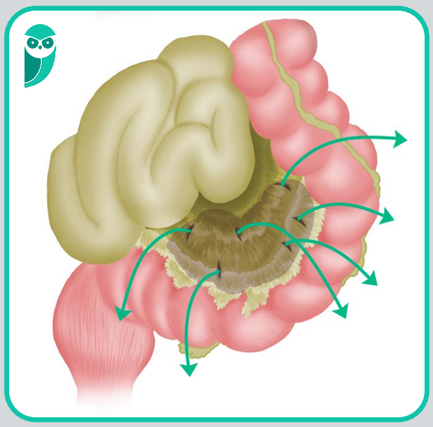
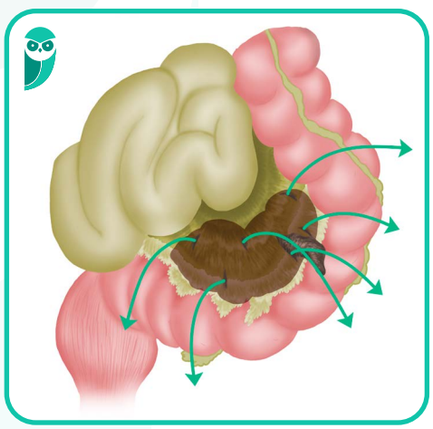
## CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY




Estágio I: abcesso mesentérico ou pericólico pequeno, confinado;
Estágio II: abscesso pélvico bloqueado;
Estágio III: peritonite purulenta generalizada; e
Estágio IV: peritonite fecal generalizada.

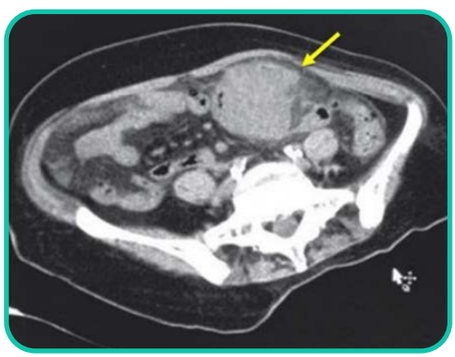
Muitas bancas cobram a Classificação de Hinchey modificada por Kaiser:

| Estágio | Características | Tratamento | Representação |
|---|---|---|---|
| 0 | Diverticulite leve, não complicada: espessamento parietal e discreto borramento da gordura. | Suporte clínico e antibióticos. Sem necessidade de internação. | |
| Ia | Inflamação/fleimão pericólico confinado. **Sem abscesso.** | Suporte clínico e antibióticos. | |
| Ib | Abscesso pericólico, confinado ao mesentério. | • Abscesso < 4 cm: suporte clínico e antibióticos.<br>• Abscesso ≥ 4 cm: drenagem percutânea. |  |
| II | Abscesso pélvico à distância (pelve ou retroperitônio). | • Abscesso < 4 cm: suporte clínico e antibióticos.<br>• Abscesso ≥ 4 cm: Drenagem percutânea. |  |

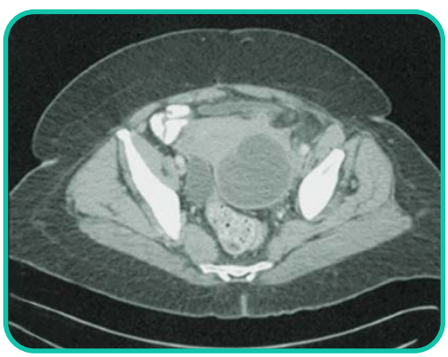
| Estágio | Características | Tratamento | Representação |
|---|---|---|---|
| III | Peritonite purulenta devido à ruptura do abscesso. | Laparotomia e Hartmann<br>Obs.: alguns autores defendem a laparoscopia para drenagem e irrigação estando o paciente estável (Sabiston). |  |
| IV | Peritonite fecal. | Laparotomia e Hartmann. |  |



Hinchey 0



Hinchey 1



Hinchey 2

Fonte: Prova de acesso direto SMS SP, 2017 (primeira imagem); imagem adaptada da prova de acesso direto FAMEMA, 2019 (segunda imagem); e imagem adaptada do Livro "Tratado de Cirurgia", Sabiston, 20ª edição (terceira imagem).




Uma outra classificação da diverticulite aguda, pouco cobrada nas provas de Residência, é a Classificação de WSES (Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência), publicada em 2015. Veja, na tabela a seguir, a classificação:

| Estágio | Descrição |
|---|---|
| Estágio 0 (não complicada) | Diverticulos, espessamento da parede do cólon ou aumento da densidade da gordura pericólica |
| Estágio 1a | Bolhas de ar pericólicas ou pouco líquido sem abscesso (dentro de de 5 cm e o segmento intestinal inflamado) |
| Estágio 1b | Abscesso ≤ 4 cm |
| Estágio 2a | Abscesso > 4 cm |
| Estágio 2b | Ar distante (> 5 cm do segmento intestinal inflamado) |
| Estágio 3 | Líquido difuso sem pneumoperitônio (sem orifício no cólon) |
| Estágio 4 | Líquido difuso com pneumoperitônio (orifício persistente no cólon) |

## 1.8.2 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE NÃO COMPLICADA

A diverticulite aguda não complicada, classificada por alguns autores como Hinchey 0, apresenta apenas discreto espessamento da parede dos divertículos, com aumento da densidade da gordura pericolônica à tomografia computadorizada. Não há sinais de complicações, como a formação de abscessos e peritonite. Pode ser tratada sem necessidade de internação hospitalar, com uso de antibióticos via oral, além de sintomáticos e dieta líquida/leve sem resíduos. Só devemos estar mais atentos aos pacientes imunossuprimidos, idosos > 70 anos e com comorbidades significativas.

O tratamento ambulatorial da diverticulite aguda geralmente consiste em antibióticos orais por 7 a 10 dias, sendo que a maioria dos pacientes apresenta melhora significativa dos sintomas após 48 horas. Os pacientes são reavaliados clinicamente dois a três dias após o início da antibioticoterapia e semanalmente até a resolução completa de todos os sintomas. Estudos de imagem repetidos não são indicados, a menos que o paciente não melhore clinicamente. Pacientes que falham no tratamento ambulatorial são admitidos para tratamento hospitalar e devem repetir a tomografia.

Os antibióticos usados no tratamento da diverticulite devem cobrir a flora gastrointestinal usual, ou seja, bastonetes Gram-negativos e anaeróbios, particularmente *Escherichia coli* e *Bacteroides fragilis*. São exemplos de esquemas de antibióticos ambulatoriais por via oral em pacientes adultos com função renal e hepática normal:

- ✓ Ciprofloxacina (500 mg 12/12 hs) ou levofloxacina (500 mg/dia) ou sulfametoxazol-trimetoprima (800/160 mg 8/8 hs) associados ao metronidazol (500 mg 8/8 hs);

- ✓ Amoxicilina-clavulanato (875/125 mg 8/8 hs); e
- ✓ Moxifloxacina (400 mg/dia).

Após o tratamento da diverticulite não complicada, os pacientes são submetidos à colonoscopia em seis a oito semanas, caso não o tenham feito no ano anterior, para confirmar a presença de divertículos e excluir neoplasia colorretal ou outras patologias que podem mimetizar a diverticulite, como a doença inflamatória intestinal (DII).



## RESUMINDO

**DIVERTICULITE AGUDA NÃO COMPLICADA**

**TOMOGRAFIA**: discreto espessamento diverticular e borramento da gordura pericolônica.

**TRATAMENTO**: AMBULATORIAL, com antibióticos via oral contra bactérias Gram-negativas e anaeróbias, sintomáticos e dieta sem resíduos.

**FALHA DO TRATAMENTO**: internação para antibioticoterapia endovenosa e repetir a tomografia (avaliar complicações).

---

## 1.8.3 TRATAMENTO DA DIVERTICULITE COMPLICADA

A diverticulite complicada **exige tratamento hospitalar** com antibióticos endovenosos, jejum para repouso intestinal, hidratação, analgesia e, a depender da complicação, drenagem percutânea de abscesso, guiada por exame de imagem, ou laparotomia com ressecção intestinal.

Em relação aos analgésicos, a morfina deve ser evitada, por aumentar a pressão intracolônica, sendo a meperidina indicada por fazer o relaxamento da musculatura lisa do cólon.

Os antibióticos endovenosos contra bactérias Gram-negativas e anaeróbias permanecem até melhora clínica da dor e sensibilidade abdominal, geralmente de 3 a 5 dias, quando são trocados para via oral e mantidos até completar 10 a 14 dias. Como exemplo de esquema antibióticos, podemos citar: ceftriaxona/cefotaxima/levofloxacina associados ao metronidazol; piperacilina-tazobactam como agente único.

Em geral, Hinchey I e II podem ser tratados sem cirurgia, com antibióticos e drenagem percutânea do abscesso (depende do tamanho), enquanto as diverticulites Hinchey III e IV requerem intervenção cirúrgica. Uma novidade que já foi cobrada em prova — está no Sabiston, 20ª edição — é que a diverticulite Hinchey III pode ser tratada com laparoscopia, irrigação da cavidade com soro aquecido e drenagem, sem necessidade de ressecção intestinal e colostomia.



## RESUMINDO

**HINCHEY IA**: antibioticoterapia endovenosa.

**HINCHEY IB E II**:

Abscesso não passível de drenagem (< 4 cm): antibioticoterapia endovenosa; e

Abscesso passível de drenagem (≥ 4 cm): antibioticoterapia endovenosa e drenagem percutânea guiada por exame de imagem (ultrassonografia ou tomografia). Manter dreno até um débito mínimo (< 10 ml/24 hs).

**HINCHEY III E IV**: antibioticoterapia endovenosa e laparotomia com cirurgia de Hartmann.

*Alguns autores defendem a laparoscopia, irrigação da cavidade com soro aquecido e drenagem da cavidade para diverticulite Hinchey III.

* Se houver falha no tratamento conservador com antibioticoterapia e/ou drenagem percutânea, a conduta será cirúrgica, com ressecção do segmento acometido, geralmente o sigmoide. E, se não houver grande contaminação da cavidade, já que se trata de abscessos bloqueados, uma anastomose primária pode ser realizada.

* Falha no tratamento conservador = aumento da dor abdominal, febre persistente, desenvolvimento de peritonite difusa, aumento da leucocitose.

NOVIDADE!

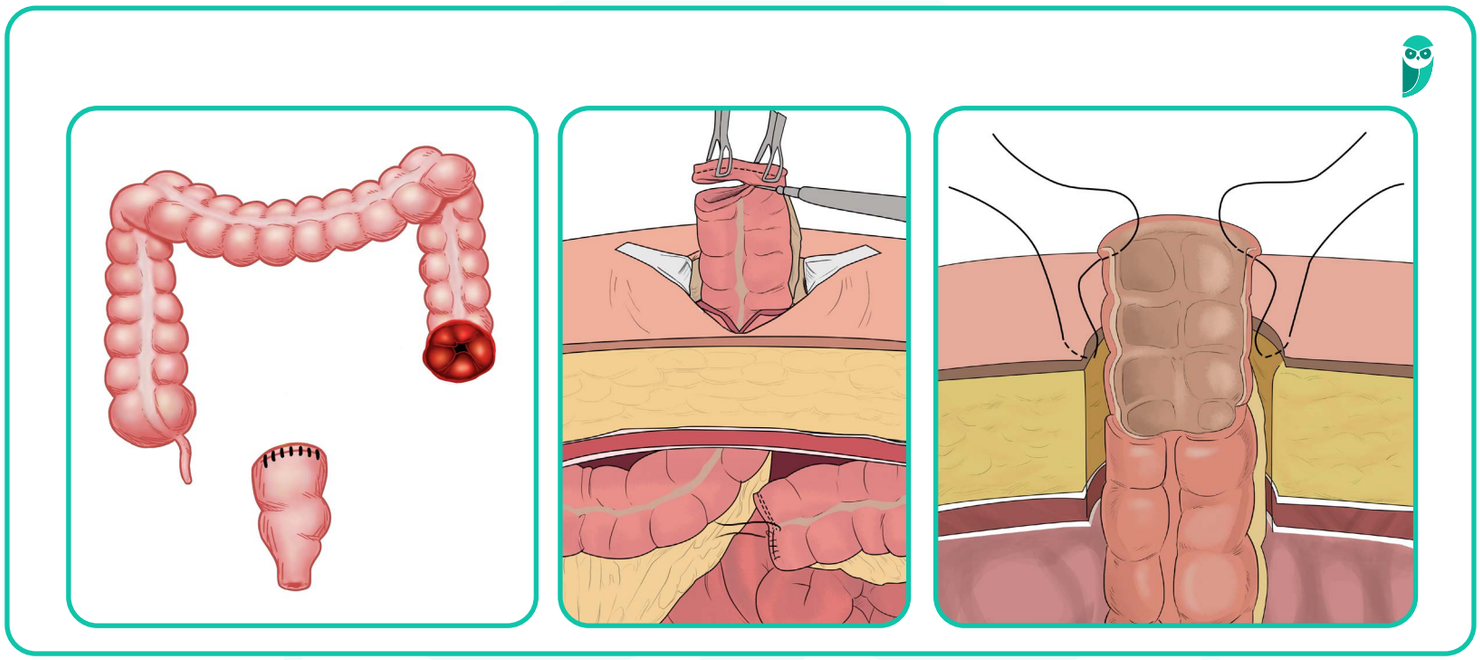


**DIVERTICULITE HINCHEY III (SABISTON)**

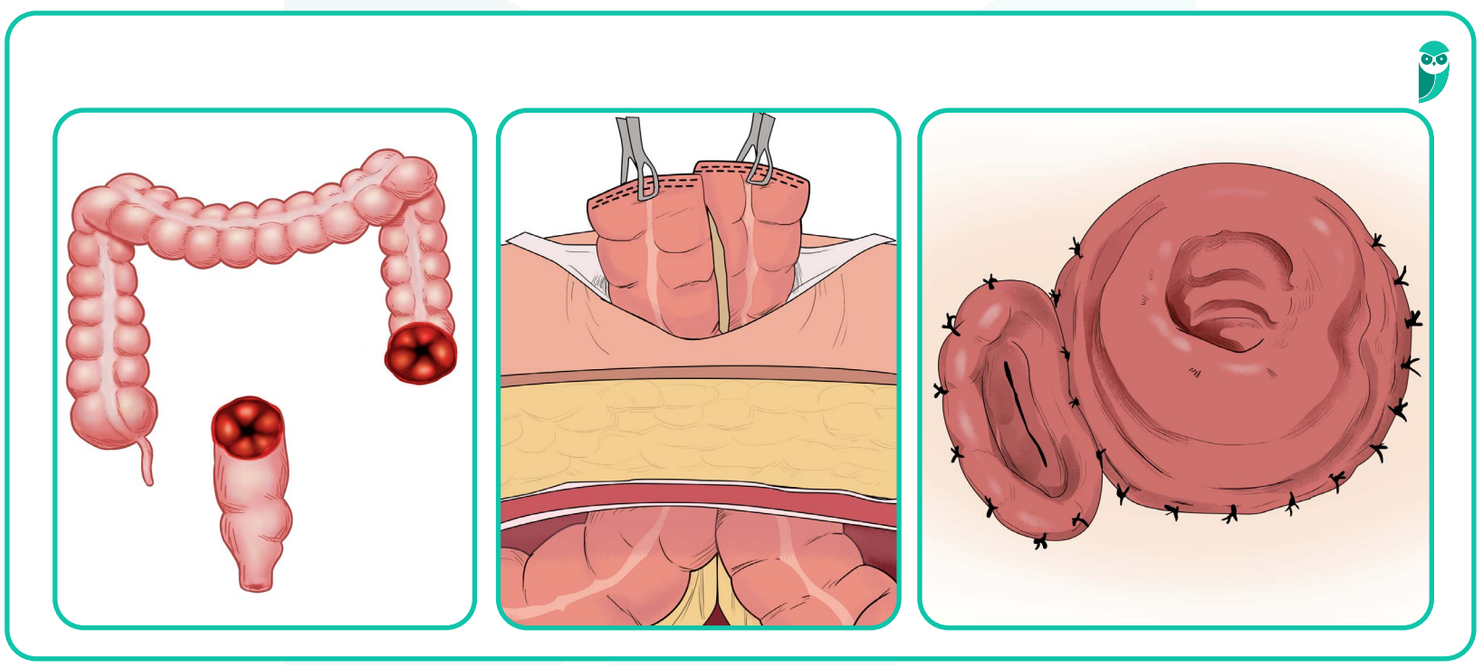
**Laparoscopia com irrigação e drenagem da cavidade abdominal.**

Alguns conceitos cirúrgicos são importantes:

**CIRURGIA DE HARTMANN**: consiste na ressecção do segmento intestinal acometido (geralmente o sigmoide), colostomia terminal proximal e fechamento do coto retal. A anastomose primária colorretal é contraindicada na diverticulite Hinchey III e IV, ou seja, diante de uma peritonite purulenta e fecal, devido à contaminação peritoneal, bem como na presença de instabilidade hemodinâmica. Em um segundo tempo, é refeito o trânsito intestinal, geralmente após 3 meses.



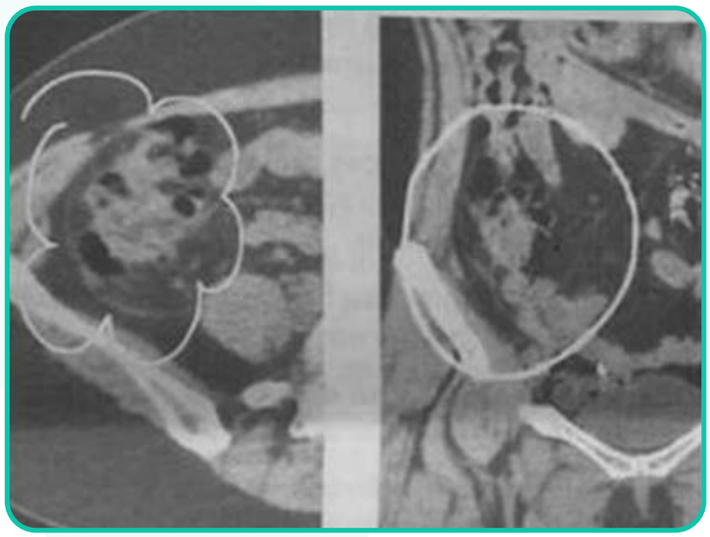
**FÍSTULA MUCOSA**: uma opção à cirurgia de Hartmann, porém não muito usada. Consiste na ressecção intestinal, colostomia terminal do coto proximal e do distal. Tem como vantagem ser tecnicamente mais fácil a reconstrução intestinal posterior, pois não é necessária abertura da cavidade abdominal por laparotomia. O fechamento é realizado no local da ostomia e reintroduzida na cavidade pelo próprio orifício.



### 1.8.4 DIVERTICULITE DO LADO DIREITO

Os divertículos do lado direito (cecal) representam apenas 1,5% dos casos de diverticulite nos países ocidentais e 38% a 75% dos casos de diverticulite nos países asiáticos. Os pacientes são mais jovens e complicações são menos prováveis. Devemos estar atentos aos diagnósticos diferenciais, como apendicite aguda, diverticulite de Meckel, adenite mesentérica, dentre outros. O tratamento vai depender da gravidade da doença, podendo ser feito com antibióticos e até uma hemicolectomia direita.

Pacientes que têm episódios recorrentes ou doença complicada devem ser considerados para a ressecção eletiva, com uma colectomia direita.



Diverticulite cecal. Fonte: Prova de acesso direto IAMSPE, 2020.

## CAI NA PROVA

**(AL - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ - SCMM 2023)** Paciente feminina, 80 anos, internada com diverticulite aguda, submeteu-se à tomografia de abdome com contraste endovenoso que evidenciou processo inflamatório colônico com divertículos e a presença de coleção pélvica bloqueada. Trata-se de diverticulite aguda, classificada por Hinchey (clássica) em grau:

**A)** II.
**B)** III.
**C)** IV.
**D)** IV.

## COMENTÁRIOS

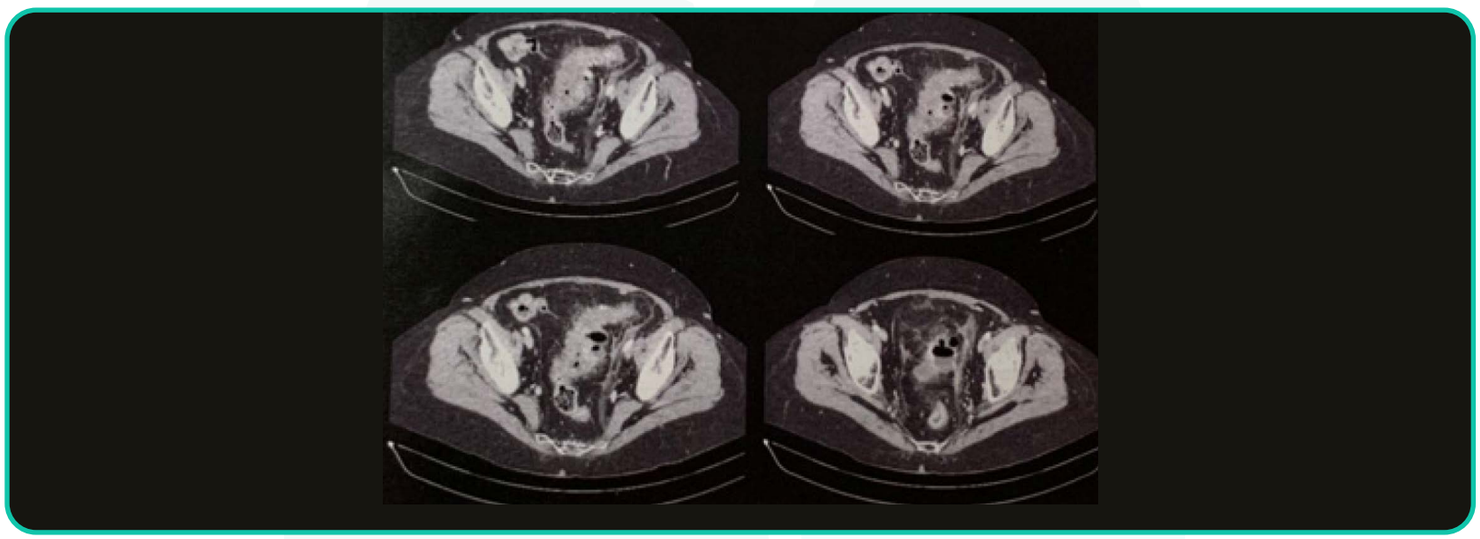
Questão direta sobre a classificação de Hinchey.

- Estágio I: abscesso mesentérico ou pericólico pequeno, confinado.
- Estágio II: abscesso pélvico bloqueado.
- Estágio III: peritonite purulenta generalizada.
- Estágio IV: peritonite fecal generalizada.

Logo, uma coleção bloqueada na pelve é classificada como Hinchey II.

**Gabarito: alternativa A.**

**(HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO VASCONCELOS - HPEV 2023)** Mulher, 68 anos de idade, procurou pronto atendimento por dor hipogástrica há dois dias. Foi realizad(o exame de urina tipo I, com o seguinte resultado: hemácias ausentes, leucócitos 30.000/mm³, nitrito negativo. Recebeu diagnóstico de infecção urinária, sendo prescrito ciprofloxacino por 3 dias. Persistiu com o sintoma e apresentou episódios febris de até 38,5 ºC, retornando ao pronto atendimento. Tem antecedente pessoal de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, com temperatura 38,5 ºC, pressão arterial 124 x 82 mmHg, frequência cardíaca 88 bpm. Abdome globoso, flácido, doloroso à palpação do hipogástrio, com plastrão palpável, sem sinais de peritonismo difuso. Os exames laboratoriais mostram: hemoglobina 13,2 g/dL (VR 11,5 - 14,9 g/dL); leucócitos 18.900/mm³ (VR 4.000-10.000/mm³); proteína C reativa 218 mg/L (VR < 3 mg/L); glicemia 301 mg/dL; restante dos exames normais. Urina tipo I: hemácias ausentes, leucócitos 35.000/mm³ (VR < 10.000/mm³), nitrito negativo. Realizou a tomografia computadorizada de abdome total, mostrada a seguir. Em relação ao caso clínico apresentado, podemos afirmar que:



**A)** se trata de diverticulite aguda complicada, com indicação de antibioticoterapia endovenosa.

**B)** se trata de pielonefrite obstrutiva, com indicação de antibioticoterapia endovenosa e desobstrução com cateter duplo J.

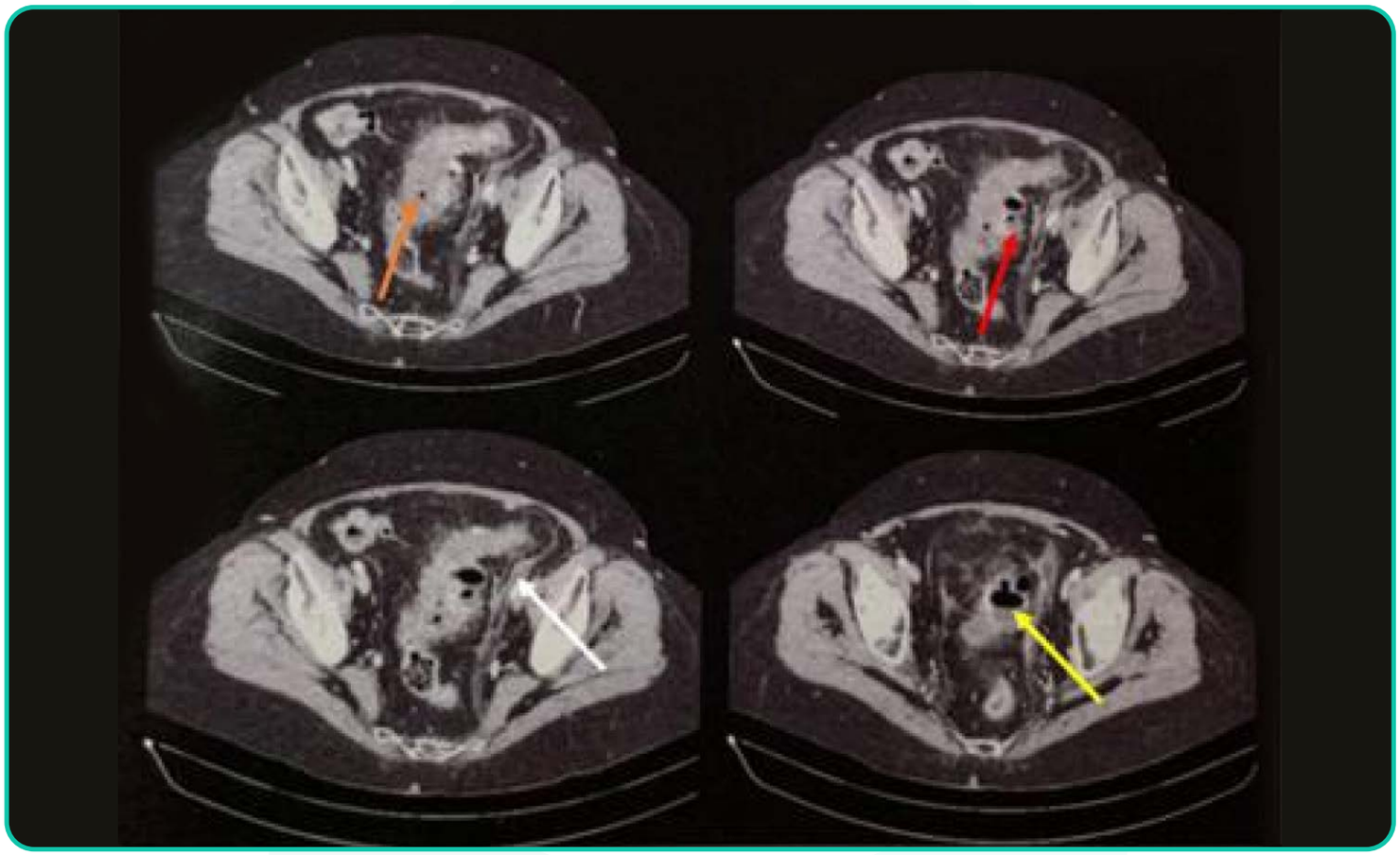
**C)** se trata de cistite enfisematosa, com indicação de coleta de urocultura e antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro.

**D)** se trata de abscesso tubo-ovariano à esquerda, com indicação de antibioticoterapia endovenosa e salpingooforectomia esquerda.

## COMENTÁRIOS

Sempre que estivermos diante de um paciente, principalmente idoso, com dor em hipogástrio ou quadrante inferior esquerdo associada ou não a massa palpável no local, devemos desconfiar de diverticulite aguda. A diverticulite aguda é uma doença intestinal causada por inflamação dos divertículos. Os divertículos são herniações das camadas internas da parede intestinal através da camada média que ocorrem em qualquer porção do cólon, sendo mais comuns à esquerda (sigmoide). Sintomas urinários, como urgência miccional, podem ser atribuídos à extensão do processo inflamatório para as estruturas do trato urinário ou a presença de fístula colovesical.

O que vemos na imagem fornecida?



Estamos diante de 04 imagens axiais do abdome com contraste que demonstram alterações típicas da diverticulite aguda complicada:

- seta laranja — espessamento parietal do cólon sigmoide;
- seta vermelha — divertículos cólicos;
- seta branca — densificação e acúmulos líquidos adjacentes à diverticulite;
- seta amarela — abscesso pericólico de pequenas dimensões.

Logo, temos um quadro de diverticulite, classificado como Hinchey I (abscesso mesentérico ou pericólico pequeno, confinado), com indicação de internação e antibioticoterapia parenteral.

**Correta a alternativa A.** Trata-se de diverticulite aguda complicada, com indicação de antibioticoterapia endovenosa.

**Incorreta a alternativa B.** A pielonefrite obstrutiva apresentaria sintomas como dor lombar, vômitos e o padrão de imagem característico é o nefrograma estriado. Nem vemos os rins nas imagens fornecidas.

**Incorreta a alternativa C.** A cistite enfisematosa é uma complicação infecciosa característica de pacientes diabéticos com gás na parede da bexiga. As imagens tomográficas nem apresentam a bexiga.

**Incorreta a alternativa D.** Os achados de imagem são sugestivos de diverticulite aguda complicada, não há abscesso tubo-ovariano na tomografia apresentada.

**(SP - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-SP 2022)** Uma mulher de sessenta anos de idade, com antecedente de diabetes e hipertensão arterial sistêmica, procurou atendimento médico por dor na fossa ilíaca esquerda, associada à febre, há quatro dias. Apresentava-se em bom estado geral, sem sinais de sepse e com abdome com defesa na fossa ilíaca esquerda. Realizou tomografia computadorizada de abdome, que evidenciou cólon sigmoide com divertículos com espessamento e borramento da gordura adjacente.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata mais adequada.

**A)** Antibioticoterapia e colonoscopia em quatro a seis semanas.

**B)** Antibioticoterapia e colonoscopia nesse momento.

**C)** Antibioticoterapia e retossigmoidectomia em quatro a seis semanas.

**D)** Antibioticoterapia e retossigmoidectomia nesse momento.

**E)** Antibioticoterapia e retossigmoidectomia nesse momento, caso a colonoscopia mostre neoplasia de sigmoide.

## COMENTÁRIOS

Sempre que estivermos diante de um paciente idoso com dor em fossa ilíaca esquerda, devemos pensar na hipótese diagnóstica de diverticulite aguda. Nesse caso, temos um quadro de diverticulite aguda não complicada.

**Correta a alternativa A.** Nossa paciente apresenta um quadro de diverticulite aguda não complicada, que pode ser tratada ambulatorialmente, com antibioticoterapia via oral contra bactérias Gram-negativas e anaeróbias e dieta sem resíduos.

Todos os pacientes com diagnóstico de diverticulite aguda devem realizar uma colonoscopia após 6 a 8 semanas do quadro agudo, para confirmar o diagnóstico de doença diverticular e descartar uma neoplasia colorretal.

**Incorreta a alternativa B.** A colonoscopia está contraindicada durante o quadro agudo de diverticulite aguda, pois pode "destamponar" uma pequena perfuração bloqueada e agravar o quadro da paciente.

**Incorreta a alternativa C.** Não há indicação de tratamento cirúrgico eletivo para diverticulite aguda não complicada (exceção para imunodeprimidos). Logo falaremos sobre isso!

**Incorreta a alternativa D.** Como foi dito anteriormente, nossa principal hipótese diagnóstica é uma diverticulite aguda, por ser um quadro agudo, com dor e sensibilidade abdominal associada à febre. Dessa forma, a colonoscopia está contraindicada nesse momento, e não temos indicação de retossigmoidectomia por se tratar de diverticulite aguda não complicada.

---

**(FAMEMA 2022)** De acordo com a classificação de WSES 2015, um paciente com quadro de diverticulite e TC, demonstrando níveis líquidos do cólon e do delgado associados a espessamento parietal do cólon e paniculite, é definido como sendo:

**A)** 0.

**B)** 1a.

**C)** 1b.

**D)** 2a.

## COMENTÁRIOS

Não é comum cair, em provas de Residência, essa classificação da diverticulite aguda da WSES (Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência), que, junto com outras instituições internacionais, desenvolveram diretrizes para o diagnóstico e tratamento da diverticulite aguda do cólon esquerdo em pacientes idosos.

Veja, na tabela a seguir, a classificação:

| Estágio | Descrição |
|---|---|
| Estágio 0 (não complicada) | Diverticulos, espessamento da parede do cólon ou aumento da densidade da gordura pericólica |
| Estágio 1a | Bolhas de ar pericólicas ou pouco líquido sem abscesso (dentro de de 5 cm e o segmento intestinal inflamado) |
| Estágio 1b | Abscesso ≤ 4 cm |
| Estágio 2a | Abscesso > 4 cm |
| Estágio 2b | Ar distante (> 5 cm do segmento intestinal inflamado) |
| Estágio 3 | Líquido difuso sem pneumoperitônio (sem orifício no cólon) |
| Estágio 4 | Líquido difuso com pneumoperitônio (orifício persistente no cólon) |

Dessa forma, uma TC com espessamento parietal do cólon e paniculite é definida como sendo diverticulite aguda não complicada, estágio 0 de WSES.

**Correta a alternativa A.**

---

**(FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - FMP - UNIFASE 2023)** Paciente de 80 anos, hipertenso e diabético, dá entrada na emergência com queixa de dor abdominal em flanco esquerdo de evolução há 5 dias. Exames complementares mostram leucocitose com desvio à esquerda, aumento de PCR e tomografia com múltiplos divertículos colônicos e formação de abscesso perissigmoidiano próximo à parede abdominal de 8 x 4 cm. Qual é o tratamento mais adequado?

**A)** Dieta oral zero e laparotomia com sigmoidectomia a Hartmann.
**B)** Antibioticoterapia venosa exclusiva.
**C)** Laparotomia com lavagem da cavidade abdominal por tratar-se de uma diverticulite Hinchey 4.
**D)** Drenagem percutânea do abscesso com antibiótico venoso.

## COMENTÁRIOS

Estamos diante de um paciente idoso com quadro de diverticulite aguda Hinchey I, com abscesso de 8 x 4 cm, indicação de antibioticoterapia e drenagem percutânea do abscesso.

Incorreta a alternativa A. Esse seria o tratamento para diverticulite aguda Hinchey III e IV.

Incorreta a alternativa B. Esse seria o tratamento para diverticulite aguda Hinchey I, com abscesso não passível de drenagem, menor do que 4 cm.

Incorreta a alternativa B. Não há indicação de laparotomia. Além disso, a diverticulite de nosso paciente é classificada como Hinchey I.

**Correta a alternativa D.** Como vimos, essa é a conduta mais adequada.

**(SP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO - SCMRP 2022)** A prevalência de moléstia diverticular dos cólons aumentou significativamente no último século e, em geral, ela é assintomática; porém alguns pacientes podem evoluir para peritonite por diverticulite aguda perfurada. Nessa situação, a abordagem mais indicada atualmente e com menores taxas de morbimortalidade é a:

**A)** drenagem percutânea guiada por ultrassonografia POCUS.
**B)** colostomia em 2 bocas à montante do segmento cólico comprometido.C
**C)** ressecção cirúrgica do segmento comprometido pelo método de Hartmann.
**D)** antibioticoterapia sistêmica prévia por 10 dias e drenagem por sucção.
**E)** lavagem e drenagem da cavidade abdominal por laparoscopia.

## COMENTÁRIO

O tratamento padrão da diverticulite aguda complicada com peritonite purulenta (Hinchey III) e fecal (Hinchey IV) é a cirurgia de Hartmann (ressecção intestinal, colostomia terminal e sepultamento do coto retal). Mas, atualmente, alguns autores defendem o uso de laparoscopia com irrigação e drenagem da cavidade para peritonite purulenta (apenas para Hinchey III).

A questão não foi clara se é uma peritonite purulenta ou fecal, por isso caberia recurso (peritonite fecal sempre tem indicação de Hartmann).

**Incorreta a alternativa A:** drenagem percutânea guiada por ultrassonografia ou tomografia está indicada para diverticulite com abscesso passível de drenagem (geralmente ≥ 4 cm), seja Hinchey I ou II.
**Incorreta a alternativa B:** colostomia em 2 bocas à montante do segmento cólico comprometido não trata a diverticulite, por isso não é um tratamento aceito para diverticulite.
**Incorreta a alternativa C:** ressecção cirúrgica do segmento comprometido pelo método de Hartmann é a cirurgia padrão para diverticulite Hinchey IV.
**Incorreta a alternativa D:** drenagem por sucção também não é conduta para diverticulite aguda.

**Correta a alternativa E:** lavagem e drenagem da cavidade abdominal por laparoscopia é uma conduta atual para o tratamento da diverticulite aguda Hinchey III, com menores taxas de morbimortalidade.

---

**(FAMEMA 2019)** Homem, 46 anos, sabidamente portador de doença diverticular, procura o pronto-socorro com queixa de dor em região da fossa ilíaca e flanco esquerdos associada a febre e calafrios. Nega parada de evacuação e está eliminando gases. Pressão arterial é de 160 x 90 mmHg, pulso de 102 batimentos/minuto, frequência respiratória de 18 incursões/minuto e temperatura axilar de 39 °C. O exame abdominal mostra dor localizada na região citada pelo paciente sem sinais de peritonite. A tomografia computadorizada de abdome é mostrada a seguir. A hipótese diagnóstica e o melhor tratamento são, respectivamente,



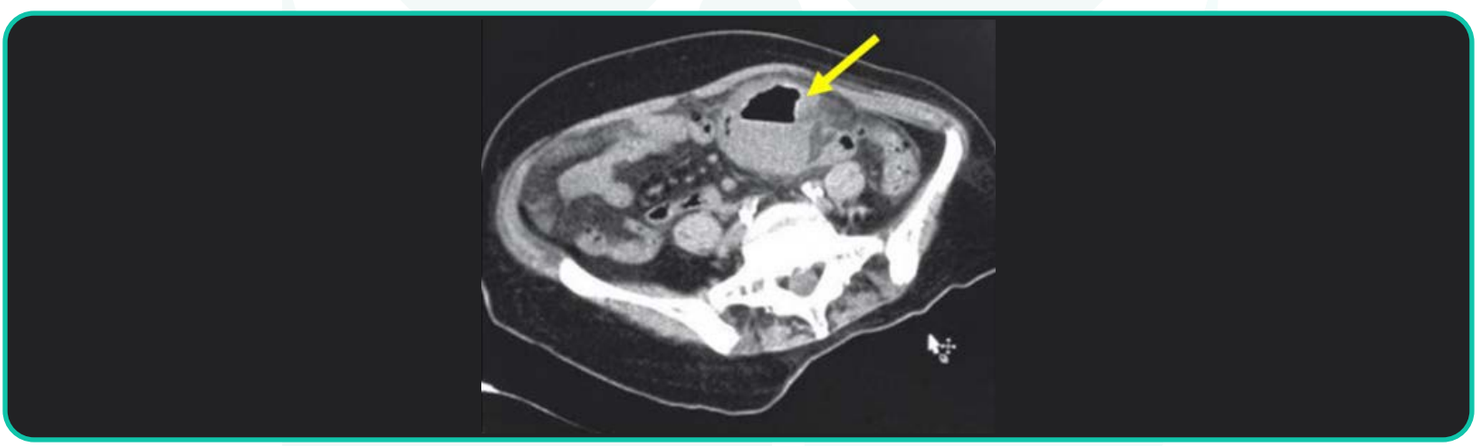
**A)** diverticulite aguda tipo Hinchey Ib; drenagem percutânea por tomografia computadorizada.
**B)** diverticulite aguda não complicada; medicação sintomática, antibioticoterapia e acompanhamento ambulatorial.
**C)** diverticulite aguda tipo Hinchey Ib; laparotomia exploradora e retossigmoidectomia à Hartmann.
**D)** diverticulite aguda tipo Hinchey III; laparotomia exploradora, ressecção do segmento e anastomose primária.

## COMENTÁRIO

Portador de doença diverticular, com dor em FIE e febre = diverticulite aguda!

A imagem tomográfica mostra-nos um abscesso pericolônico confinado, ou seja, estamos diante de uma diverticulite Hinchey I e, usando a classificação de Hinchey modificada por Kaiser, temos um estágio Ib. A conduta, nesses casos, vai depender do tamanho do abscesso, em que um abscesso ≥ 4 cm é tratado com drenagem percutânea guiada por exame de imagem (TC ou USG), e aqueles < 4, apenas com antibioticoterapia endovenosa.

**Correta a alternativa A** Porque, na imagem apresentada, o abscesso (seta amarela) é pericólico, um Hinchey Ib, aparentemente com mais de 4 cm, bem próximo à parede abdominal, o que facilita a drenagem percutânea.



**Incorreta a alternativa B:** porque temos um abscesso pericólico, logo a diverticulite é complicada. A diverticulite não complicada é caracterizada apenas por espessamento da parede dos divertículos, com aumento da densidade da gordura pericolônica, e pode ser tratada ambulatorialmente, com antibióticos via oral e dieta sem resíduos.
**Incorreta a alternativa C:** porque essa conduta é realizada nas diverticulites Hinchey III e IV. Lembrando que alguns autores defendem a laparoscopia com irrigação e drenagem da cavidade abdominal para diverticulite Hinchey III.
**Incorreta a alternativa D:** porque, na diverticulite aguda tipo Hinchey III, o tratamento padrão é feito com laparotomia, ressecção do segmento acometido à Hartmann (colostomia terminal). Não é aconselhável uma anastomose primária, pelo risco de deiscência.

---

**(SURCE – 2019)** Um paciente foi atendido na UPA e referido a uma emergência cirúrgica. Ele tem 62 anos, e queixa de dor abdominal em Fossa Ilíaca Esquerda (FIE) de intensidade crescente nos últimos 4 dias. Teve 3 episódios de febre (T = 38,7 °C ) nas últimas 48 horas, está taquicárdico (FC = 102 bpm), nega anorexia ou vômitos ou parada da eliminação de flatos. Ao exame abdominal, tem dor à palpação superficial e profunda localizada em FIE com ausência de descompressão brusca ou distensão abdominal ou outros sinais de irritação peritoneal. Foi realizada tomografia de abdome que revelou presença de espessamento da parede do sigmoide e de sinais sugestivos de inflamação do mesocólon correspondente, pequena coleção com conteúdo hidroaéreo pericólica de 2 cm e ausência de pneumoperitônio. Qual deve ser a conduta proposta?

**A)** Internar o paciente com prescrição de jejum e antibióticos parenterais.
**B)** Contra referir o paciente à UPA para tratamento clínico conservador.
**C)** Solicitar colonoscopia para confirmar o diagnóstico de diverticulite.
**D)** Indicar e encaminhar para laparotomia de urgência.

## COMENTÁRIO

Aqui estamos diante de um quadro de diverticulite aguda complicada com um pequeno abscesso pericolônico, ou seja, um Hinchey Ib. Nessa questão, o autor coloca o tamanho do abscesso, apenas 2 cm, cujo tratamento de escolha é internação hospitalar, jejum, antibioticoterapia endovenosa contra Gram-negativos e anaeróbios, por 10 a 14 dias. Se houver melhora clínica e laboratorial, o paciente recebe alta e completa o esquema de antibióticos via oral.

**Correta a alternativa A** O tratamento para a diverticulite aguda complicada com abscesso pequeno, não passível de drenagem (< 4 cm), é jejum, hidratação venosa, correção de distúrbios hidroeletrolíticos e prescrição de antibioticoterapia endovenosa.

**Incorreta a alternativa B:** o tratamento da diverticulite complicada com abscesso é feito em regime hospitalar. O tratamento ambulatorial é para diverticulite não complicada.

**Incorreta a alternativa C:** a colonoscopia é CONTRAINDICADA nos casos de diverticulite, pelo risco de perfuração livre e evolução para peritonite difusa. Ela tem indicação após 6 a 8 semanas da resolução da diverticulite.

**Incorreta a alternativa D:** a laparotomia de urgência está indicada nos casos de diverticulite com peritonite difusa, ou seja, Hinchey III e IV.

---

**(PR - ALIANÇA SAÚDE - PUC-PR 2023)** Paciente de 54 anos procura atendimento por quadro de dor abdominal em fossa ilíaca esquerda. Ao exame físico, encontra-se estável, com dor à palpação da porção inferior esquerda do abdome. A tomografia de abdome revela espessamento parietal do sigmoide, com presença de divertículos e densificação da gordura local. Assinale a alternativa CORRETA sobre o caso.

**A)** O paciente pode receber tratamento clínico por meio de antibioticoterapia com ceftriaxona e metronidazol.
**B)** O paciente apresenta indicação cirúrgica, devendo ser realizada em até 72 horas.
**C)** O paciente apresenta indicação de terapia endoscópica por meio de colonoscopia descompressiva.
**D)** O paciente deve ser internado, porém não há necessidade de terapia com antibióticos, sendo indicado tratamento conservador com uso de laxativos e dieta pobre em sementes.
**E)** O paciente apresenta um quadro de abdome agudo inflamatório, com indicação cirúrgica imediata.

## COMENTÁRIOS

Estamos diante de um típico quadro de diverticulite aguda não complicada, com indicação de antibioticoterapia via oral e orientação de dieta sem resíduos.

**Correta a alternativa A:** essa é a conduta correta para quadros de diverticulite aguda não complicada, ou seja, antibioticoterapia com espectro para bactérias Gram-negativas e anaeróbias por via oral e dieta sem resíduos.

**Incorreta a alternativa B:** não há indicação cirúrgica para diverticulite aguda não complicada.

**Incorreta a alternativa C:** esse seria o tratamento para volvo de sigmoide, não para diverticulite aguda.

**Incorreta a alternativa D:** sempre tratamos a diverticulite com antibioticoterapia.

**Incorreta a alternativa E:** o paciente tem um quadro de abdome agudo inflamatório, sem indicação de tratamento cirúrgico.

**SUS SP 2018)** Tratamento mais apropriado para a diverticulite Hinchey IV (peritonite fecal):

**A)** Drenagem percutânea (radiologia intervencionista).
**B)** Laparotomia com cirurgia de Hartmann.
**C)** Antibiótico e observação clínica rigorosa.
**D)** Colostomia em alça.
**E)** Laparoscopia para irrigação e drenagem.

## COMENTÁRIO

Se tem uma conduta que todos os autores concordam, é o tratamento da diverticulite aguda Hinchey IV, ou seja, uma peritonite fecal!!! É realizada uma laparotomia de urgência, ressecção intestinal (geralmente o sigmoide), colostomia terminal e fechamento do coto retal distal, denominado de cirurgia de Hartmann. Vamos às alternativas.

**Incorreta a alternativa A:** a drenagem percutânea está indicada nos casos de diverticulite Hinchey Ib ou II, com abscesso pericólico ou pélvico ≥ 4 cm.

**Correta a alternativa B** A cirurgia de Hartmann é o tratamento para a diverticulite complicada com peritonite fecal, Hinchey IV.

**Incorreta a alternativa C:** antibioticoterapia e observação clínica estão indicadas para a Diverticulite Hinchey Ia e Ib (abscessos pequenos não passíveis de drenagem, < 4 cm).

**Incorreta a alternativa D:** colostomia em alça não é uma cirurgia para tratamento de diverticulite.

Incorreta a alternativa E: laparoscopia com irrigação e drenagem é uma conduta aceita para o tratamento da diverticulite Hinchey III.

---

**(SCMBH 2017)** Paciente do sexo masculino, 67 anos, dá entrada em serviço de urgência com quadro de dor abdominal em quadrante inferior esquerdo, com piora nas últimas horas, febre (38°C), e abdome com sinais de franca irritação peritoneal e presença de pneumoperitôneo em estudo radiológico. Laboratório evidencia leucocitose com desvio à esquerda e dados vitais indicam taquicardia sustentada e hipotensão. Paciente é levado imediatamente à laparotomia, sendo identificada diverticulite Hinchey estágio III. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta a MELHOR conduta a ser adotada para esse paciente.

**A)** Realizar sigmoidectomia incluindo segmento perfurado, associada à colostomia terminal.
**B)** Realizar sigmoidectomia incluindo segmento perfurado, associada à anastomose primária.
**C)** Realizar colectomia total, associada à ileostomia terminal.
**D)** Realizar a exteriorização do segmento perfurado como colostomia, associada à drenagem ampla da cavidade abdominal.

## COMENTÁRIO

**Correta a alternativa A** Porque essa é a conduta padrão nas diverticulites complicadas Hinchey III, em que há peritonite difusa. A cirurgia de escolha é a sigmoidectomia à Hartmann, com ressecção do seguimento acometido, lavagem exaustiva da cavidade abdominal e colostomia terminal. Alguns autores indicam laparoscopia com irrigação e drenagem da cavidade, mas essa também é indicada para pacientes selecionados, sendo os melhores candidatos os que não estão em sepse grave.

**Incorreta a alternativa B:** porque, diante de uma peritonite difusa, há grande risco de uma deiscência de anastomose, por esse motivo a anastomose primária não deve ser feita.

**Incorreta a alternativa C:** porque devemos ressecar apenas o segmento acometido, geralmente o sigmoide, e não o cólon inteiro.

**Incorreta a alternativa D:** porque o segmento perfurado deve ser ressecado e feita uma colostomia terminal.

**(SANTA CASA SP 2017)** Em relação ao tratamento da diverticulite aguda, é CORRETO afirmar que:

**A)** O tratamento cirúrgico deve ser sempre utilizado na presença de abcessos.
**B)** Na diverticulite Hinchey III, pode-se utilizar a videolaparoscopia para lavagem e drenagem de coleções sem ressecção do cólon acometido.
**C)** A chamada diverticulite complicada tem como sua maior e mais comum complicação a formação de fístula colo-cutânea.
**D)** O tratamento do Hinchey II, em sua maior parte, acaba sendo por meio da retossigmoidectomia.
**E)** Jejum e utilização de nutrição parenteral prolongada com antibioticoterapia de largo espectro são uma boa opção de tratamento na diverticulite aguda Hinchey IV.

## COMENTÁRIO

**Incorreta a alternativa A:** o tratamento do abscesso na diverticulite geralmente é feito com antibioticoterapia com ou sem drenagem percutânea, a depender do tamanho do abscesso. A drenagem é realizada nos abscessos maiores que 4 cm.

**Correta a alternativa B** Porque esse é um dos tratamentos propostos para a diverticulite Hinchey III.

**Incorreta a alternativa C:** porque a complicação mais comum na diverticulite é a formação de abscesso.
**Incorreta a alternativa D:** porque o tratamento da diverticulite Hinchey II, abscesso a distância (pélvico ou retroperitoneal), geralmente é feito com antibioticoterapia e drenagem percutânea, se o abscesso for maior que 4 cm.
**Incorreta a alternativa E:** porque o tratamento na diverticulite Hinchey IV (peritonite fecal) é laparotomia e colectomia à Hartmann.

## 1.9 PÓS TRATAMENTO DA DIVERTICULITE

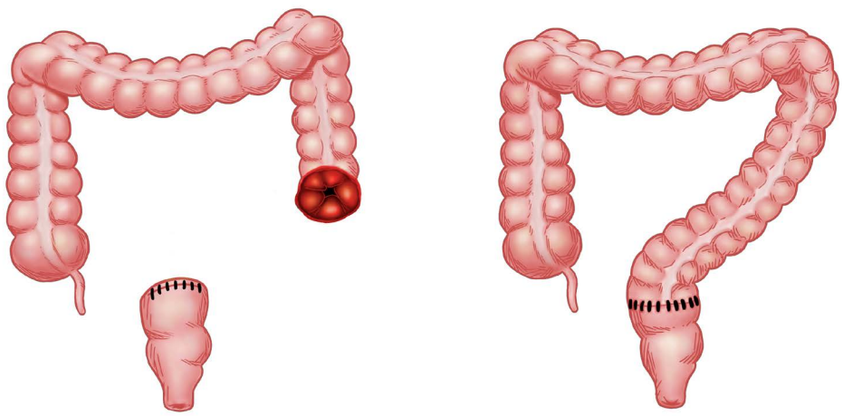
**Tratamento clínico:** em pacientes sem indicação de cirurgia, que serão observados**,** fazemos apenas modificações na dieta, que deve ser rica em fibras (>30 gramas; se necessário, suplementar), e no comportamento, como abolir o tabagismo e realizar atividades físicas para diminuir o risco de recorrência futura. Não há consenso no uso de mesalazina, um anti-inflamatório com ação na mucosa intestinal, e outros agentes como rifaximina (antibiótico) e probióticos.

**Colonoscopia**: em cerca de seis a oito semanas, os pacientes com diverticulite aguda com resolução de todos os sintomas devem ser submetidos à colonoscopia para descartar neoplasia de cólon e outras patologias, caso não tenham realizado uma colonoscopia no ano anterior. A taxa de detecção de câncer por colonoscopia é consistentemente muito maior após diverticulite complicada do que após diverticulite não complicada (8,8% a 10,8% x 0,5% a 0,7%).

## 1.10 CIRURGIA ELETIVA

Neste tópico, é importante saber as indicações de cirurgia eletiva após um quadro de diverticulite aguda.

A cirurgia eletiva costuma ser realizada após seis a oito semanas da diverticulite, devido à regressão do processo inflamatório e após colonoscopia. Consiste em preparo intestinal pré-operatório e ressecção intestinal, sempre englobando o cólon sigmoide, com a transecção distal no reto superior e anastomose primária. Não é necessário ressecar todo o cólon com divertículos próximo à anastomose pretendida para evitar a recorrência, uma vez que os divertículos no cólon transverso ou descendente raramente causam sintomas adicionais. Pode ser feita por laparoscopia, cirurgia robótica ou por via aberta convencional. A cirurgia laparoscópica apresenta menor risco de complicações pós-operatórias em comparação com a ressecção aberta, além de menos dor, recuperação mais rápida da função intestinal e internação mais curta.



Sigmoidectomia com anastomose primária

Antigamente, a cirurgia eletiva era recomendada para pacientes jovens, com menos de 40 anos, e aos que tiveram dois ou mais ataques não complicados de diverticulite, mas, nas diretrizes atuais, a idade e o número de ataques anteriores não são mais utilizados como critérios de cirurgia. Em vez disso, a cirurgia deve ser oferecida a pacientes com diverticulite recorrente que desenvolvam sintomas que podem ser atribuídos de forma convincente à doença ("diverticulite crônica") e àqueles com maior risco de desenvolver complicações ou morrer de ataques recorrentes (diverticulite complicada e imunocomprometidos).

Se a colonoscopia for negativa, a diverticulite não complicada (independentemente do número de episódios) e o paciente for imunocompetente, não há necessidade de tratamento cirúrgico, apenas orientação nutricional e mudanças comportamentais.

## RESUMINDO

**INDICAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA APÓS DIVERTICULITE AGUDA**

**SOCIEDADE AMERICANA DE CIRURGIÕES COLORRETAIS DE 2020 (ASCRS)**

1- **Diverticulite latente crônica**: paciente mantém sintomas por mais de 6 semanas (dor, sangramento, alteração do hábito intestinal).

2- **Alto risco de desenvolver complicações graves ou morrer de diverticulite recorrente**:

- Após um único episódio de diverticulite aguda complicada (abscesso, fístula, obstrução, estenose).
- Imunocomprometidos: maior risco de apresentar doença recorrente e complicada.

* O número de ataques de diverticulite aguda não complicada e idade não são mais critérios para indicação de cirurgia eletiva.

* Imunocomprometidos: capacidade diminuída de combater um processo infeccioso. Por exemplo, pacientes em quimioterapia, imunossupressão de transplantes, terapia prolongada com glicocorticoides ou com condições médicas crônicas, como diabetes, insuficiência renal, distúrbios vasculares de colágeno, como lúpus ou desnutrição.

Claro que, às vezes, precisamos usar o bom senso e considerar o risco cirúrgico em pacientes com relato de diverticulite aguda complicada, porém assintomáticos.

Agora vamos resumir as indicações de cirurgia na diverticulite? Assim fica mais fácil de memorizar.

| TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DIVERTICULITE | | |
|---|---|---|
| Urgência | Peritonite purulenta (Hinchey III) | Hartmann (tratamento padrão)<br>Laparoscopia com irrigação e drenagem abdominal (Sabiston) |
| | Peritonite fecal (Hinchey IV) | Hartmann |
| | Falha no tratamento com antibióticos e/ou drenagem (diverticulite não complicada e Hinchey I e II) | Ressecção com anastomose primária<br>(se não houver contaminação da cavidade) |
| Eletiva<br>(após 6-8 semanas)<br>Colonoscopia prévia | Paciente sintomático por mais de seis semanas (“diverticulite crônica”) | Ressecção com anastomose primária<br>*avaliar necessidade de ileostomia de proteção |
| | Após um episódio de diverticulite complicada | |
| | Imunossuprimidos* | |

# CAI NA PROVA

**(SP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE 2021)** Assinale a alternativa que apresenta a situação que tem indicação de colectomia eletiva para diverticulite e que tem o maior suporte de literatura.

**A)** Estreitamento dilatável do sigmoide.

**B)** Diverticulite Kaiser 1b, com resolução.

**C)** Diverticulite com coleção de 3 cm, que foi puncionada.

**D)** Diverticulite não complicada, associada à colelitíase.

**E)** Três surtos de diverticulite não complicada ao longo de cinco anos.

## COMENTÁRIOS

Essa questão fala sobre a indicação de cirurgia eletiva após a cri(se de diverticulite aguda. Geralmente, a cirurgia é realizada após 6 a 8 semanas do quadro de diverticulite, depois de se realizar uma colonoscopia para descartar neoplasias. A cirurgia indicada é a sigmoidectomia com anastomose primária.

São indicações de cirurgia eletiva após um quadro de diverticulite aguda:

- diverticulite latente crônica — paciente mantém sintomas (dor, sangramento, alteração do hábito intestinal);
- alto risco de desenvolver complicações graves ou morrer de diverticulite recorrente:

  *após um único episódio de diverticulite aguda complicada (fístula, obstrução, estenose, perfuração não ressecada e abscessos);

  *imunossuprimidos.

  É claro que devemos pesar o risco benefício em pacientes idosos, assintomáticos e com alto risco cirúrgico (ASA ≥ 3).

**Correta a alternativa A:** um estreitamento do cólon sigmoide é uma complicação da diverticulite aguda que pode evoluir com obstrução intestinal, por isso há indicação de cirurgia eletiva..

**Incorreta a alternativa B:** diverticulite aguda Hinchey Ib significa a presença de abscesso pericólico, que pode ser tratado com antibioticoterapia e drenagem percutânea guiada por exame de imagem (se ≥ 4 cm). Não deixa de ser uma diverticulite complicada, que teria indicação de cirurgia de eletiva, mas alguns autores preferem observar esses pacientes que evoluíram bem com o tratamento conservador de abscessos.

**Incorreta a alternativa C:** geralmente, a punção de um abscesso decorrente de diverticulite aguda é feita para coleções maiores do que 4 cm. Semelhante à alternativa anterior, alguns autores optam por observar esses pacientes que tiveram boa resposta ao tratamento conservador de um abscesso.

**Incorreta a alternativa D:** diverticulite não complicada só tem indicação de cirurgia eletiva nos pacientes imunodeprimidos e com sintomas recorrentes.

**Incorreta a alternativa E:** o número de episódios de diverticulite não complicada não é mais considerado indicação de cirurgia eletiva.

---

**(SP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE 2021)** Atualmente, a indicação cirúrgica eletiva em pacientes com diverticulite aguda não complicada baseia-se:

**A)** na idade.

**B)** no sexo.

**C)** na facilidade do procedimento por vídeo.

**D)** nos sintomas de dor persistentes, mesmo entre os episódios de crises.

**E)** nos surtos ocasionais de crise aguda e no tratamento ambulatorial.

## COMENTÁRIOS

Incorreta a alternativa A: a idade, atualmente, não é mais um critério para indicar cirurgia eletiva!

Incorreta a alternativa B: a distribuição de sexos na diverticulite alterna conforme a idade, sendo mais comum em pacientes do sexo masculino abaixo dos 50 anos e mais comum em mulheres acima dessa idade, porém não é um critério para cirurgias eletivas.

Incorreta a alternativa C: a cirurgia pode ser realizada via laparoscopia, porém seus riscos não são isentos, portanto não é uma justificativa para realizar procedimento seletivos.

**Correta a alternativa D:** também chamada de diverticulite latente crônica, quando há sintomas entre crises de diverticulite aguda, é a principal indicação de cirurgia eletiva.

Incorreta a alternativa E: o número de crises agudas não é mais uma indicação de tratamento cirúrgico eletivo, devemos levar em consideração a severidade do quadro para essa indicação.

(**SCMBH 2018)** Sobre diverticulose e diverticulite aguda dos cólons, assinale a alternativa CORRETA.

**A)** Até 40% dos portadores de divertículos colônicos permanecerão assintomáticos por toda a vida.

**B)** Mesmo os pacientes portadores de diverticulite não complicada deverão permanecer internados, devido à necessidade de suspensão completa da dieta e de soroterapia.

**C)** Pacientes com idade inferior a 40 anos deverão ter colectomia eletiva indicada após o primeiro episódio de diverticulite aguda, devido à alta incidência de recorrência e complicações.

**D)** Guidelines atuais recomendam a realização de colectomia eletiva após episódio único de diverticulite complicada.

## COMENTÁRIO

**Incorreta a alternativa A:** porque cerca de 70% a 80% dos portadores da doença diverticular são assintomáticos.

**Incorreta a alternativa B:** porque o tratamento da diverticulite aguda não complicada é clínico e pode ser ambulatorial, com dieta sem resíduos e antibioticoterapia oral de amplo espectro (cobertura para bactérias Gram-negativas e anaeróbias) por 7 a 10 dias. É importante reavaliar o paciente em 2 a 3 dias, quando geralmente apresenta melhora significativa dos sintomas.

**Incorreta a alternativa C:** porque essa era uma recomendação antiga. Atualmente, a idade e o número de episódios recorrentes de diverticulite não complicada não são mais critérios para indicar a cirurgia eletiva.

**Correta a alternativa D** Porque as diretrizes mais atuais recomendam cirurgia eletiva para pacientes com um único episódio anterior de diverticulite complicada. A cirurgia é normalmente realizada seis a oito semanas após um episódio de diverticulite aguda. A ressecção intestinal (sempre incluir o sigmoide) com anastomose primária colorretal, sem ostomia protetora, é o procedimento padrão.

---

**(HOSPITAL ADUSTA – CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA. – ADUSTA 2019)** Um homem de 39 anos procurou o pronto-socorro com dor em fossa ilíaca esquerda e febre de 38,3 °C, havia 3 dias. Leucócitos: 15.000/mm³, com desvio à esquerda. A tomografia de abdômen revelou espessamento do sigmoide, sem evidência de ar extraluminal ou líquido livre. Foi tratado com antibióticos e teve remissão completa do quadro agudo. A colonoscopia, feita 8 semanas após o quadro agudo, mostra divertículos em todo o cólon. Melhor conduta:

**A)** Acompanhamento clínico.

**B)** Colectomia total por laparotomia.

**C)** Sigmoidectomia.

**D)** Colectomia total por videolaparoscopia.

## COMENTÁRIO

Essa questão fala sobre a indicação de cirurgia eletiva após a crise de diverticulite aguda.

Antigamente, a cirurgia eletiva era recomendada para pacientes jovens, com menos de 40 anos, e aos que tiveram dois ou mais ataques não complicados de diverticulite. No entanto, nas diretrizes atuais (Sociedade Americana de Cólon e Cirurgiões Retais de 2020 - ASCRS), a idade e o número de ataques anteriores não são mais utilizados como critérios de cirurgia.

São indicações de cirurgia eletiva após um quadro de diverticulite aguda:

1- Diverticulite latente crônica: paciente mantém sintomas (dor, sangramento, alteração do hábito intestinal); e

2- Alto risco de desenvolver complicações graves ou morrer de diverticulite recorrente:

- ✓ Após um único episódio de diverticulite aguda complicada.
- ✓ Imunossuprimidos.

**Correta a alternativa A** Nosso paciente teve uma diverticulite aguda não complicada com remissão completa do quadro, ou seja, está assintomático. Logo, não tem indicação cirúrgica.

**Incorreta a alternativa B:** além do nosso paciente não ter indicação de cirurgia eletiva, a colectomia total não está indicada no tratamento eletivo após uma diverticulite. Basta a sigmoidectomia com transecção do reto distal.

**Incorreta a alternativa C:** essa é a cirurgia realizada quando há indicação de tratamento cirúrgico eletivo (sigmoidectomia com anastomose primária, de preferência por laparoscopia). Mesmo que o paciente apresente doença diverticular em todo o cólon, não há necessidade de colectomia total, uma vez que os divertículos no cólon transverso, ascendente ou descendente, raramente causam sintomas adicionais.

**Incorreta a alternativa D:** como foi dito anteriormente, nosso paciente deve fazer apenas acompanhamento clínico, sem indicação de cirurgia.

## 1.11 PROGNÓSTICO

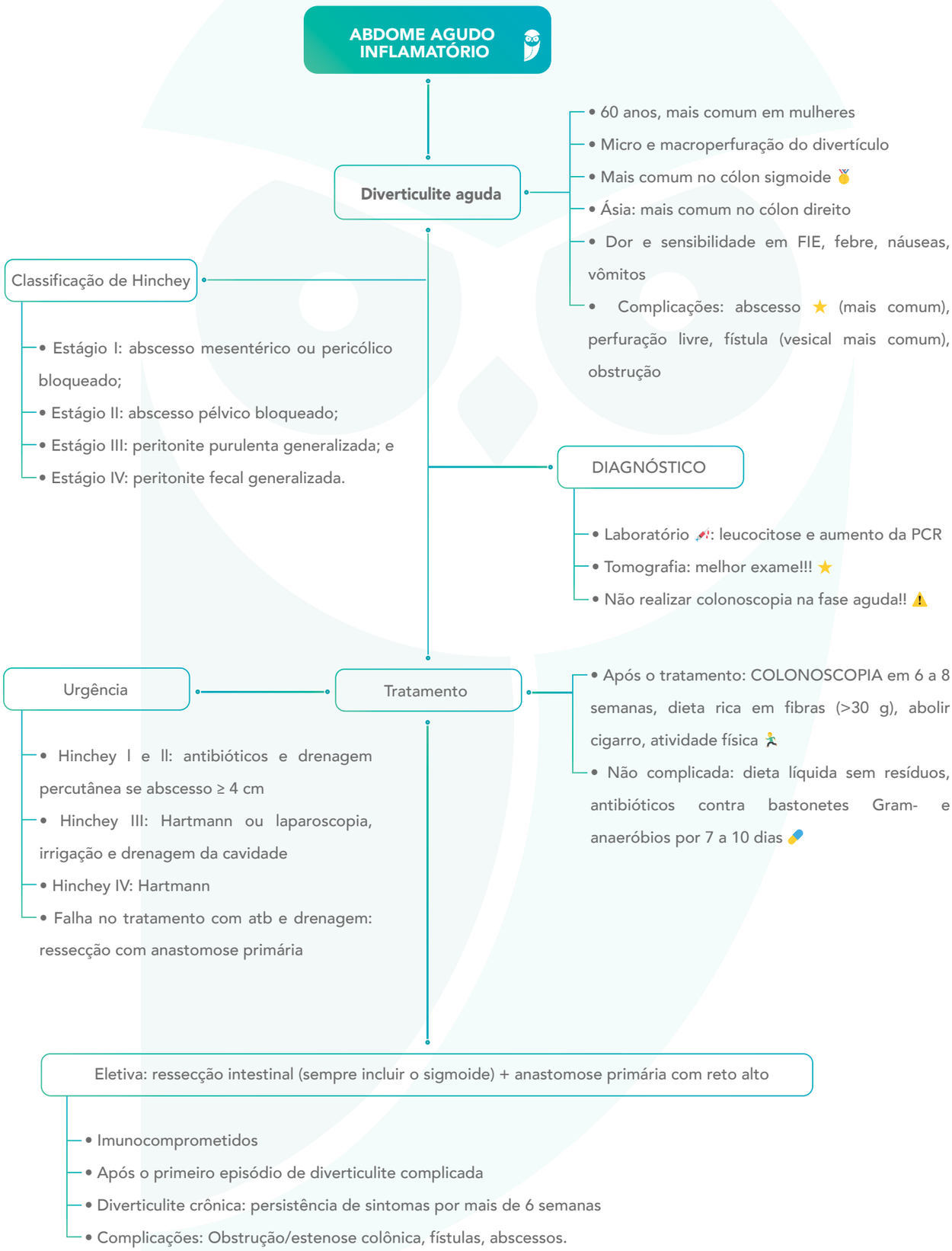
Após o tratamento não operatório de um primeiro episódio de diverticulite, aproximadamente um terço dos pacientes terá um segundo ataque, após o qual um terço terá um terceiro ataque, a maioria não complicada, sendo o risco de recorrência maior em indivíduos mais jovens e em mulheres.

A taxa de mortalidade varia de acordo com a presença de complicações e comorbidades dos pacientes. Em pacientes com diverticulite aguda não complicada, o tratamento conservador é bem-sucedido em 70% a 100% dos pacientes e a mortalidade é insignificante. A cirurgia de emergência para diverticulite perfurada aguda tem sido associada a uma taxa de mortalidade de 15% a 25% e uma taxa de morbidade de até 50%.

Os pacientes são tipicamente curados de sua doença diverticular após a cirurgia. No entanto, 15% desenvolverão novos divertículos no cólon restante e 2% a 11% exigirão nova cirurgia. As recidivas são mais prováveis se a margem de ressecção distal não for estendida para o reto.

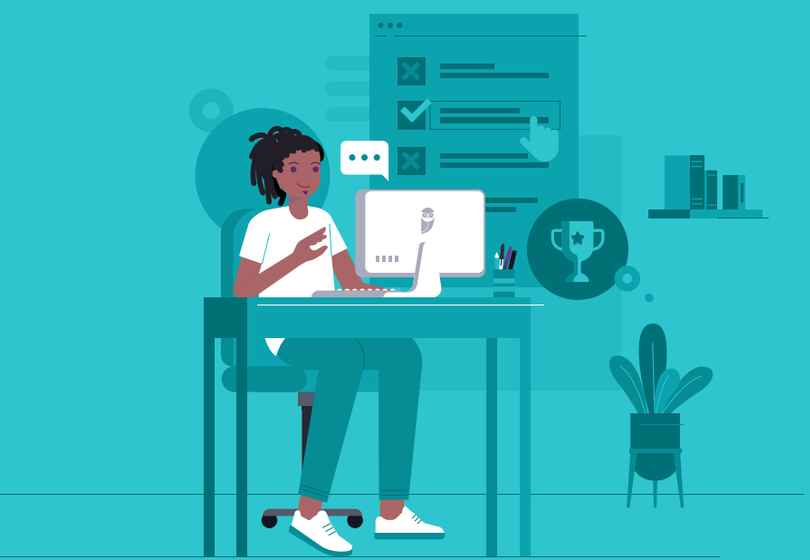
CAPÍTULO

# 2.0 MAPA MENTAL



## Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



### Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/3rWwX2l

### Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





### Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

# 4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição.
2. Diverticulose colônica e doença diverticular: epidemiologia, fatores de risco e patogênese.
3. Manifestações clínicas e diagnóstico de diverticulite aguda em adultos.
4. Diverticulite colônica aguda: tratamento médico.
5. Diverticulite colônica aguda: tratamento cirúrgico.
6. Fístulas diverticulares.


---

CAPÍTULO

# 5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, terminamos mais um capítulo muito importante sobre Abdome Agudo Inflamatório. Nos nossos livros, estão as principais patologias que são cobradas em provas. Diverticulite aguda é um tema recorrente, e, fazendo as questões, você vai perceber que quase todas se referem à Classificação de Hinchey e ao tratamento. Atenção às imagens, cada vez mais elas estão presentes nas provas.

No próximo livro, vamos dar continuidade ao Abdome Agudo, agora com o tema “Abdome agudo obstrutivo”.

Estou a sua disposição para tirar dúvidas no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED. Lembre-se, estou aqui para ajudar você a garantir sua aprovação!

Não esqueça de seguir-nos nas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos mais atuais de todas as especialidades.

Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

**Renatha Paiva**




# Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED